

Notiz_Kanzlei_Erstgespraech_Bodo.txt

04-bodo-em-rente/Notiz_Kanzlei_Erstgespraech_Bodo.txt

KANZLEI HOLM - GESPRÄCHSNOTIZ

Datum: 21. April 2026, 14:00 - 15:10 Uhr

Mandant: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964, Knooper Weg 184, 24118 Kiel

Vermittelt durch: Olaf Tannenberg (Schwager - Mandant in anderer Sache)

Anwesend: RA Holm, Bodo Petersen, Lebenspartnerin Karin Lorenzen

WORTPROTOKOLL Auszug:

Mandant: "Ich kann einfach nicht mehr. Seit der Bandscheibe geht nichts mehr richtig. Und dann kam diese Depression dazu. Ich liege manchmal Tage im Bett."

Karin Lorenzen: "Er hat es 2024 noch versucht mit Reha. Es ging eine Weile besser, dann kam wieder der Absturz. Wir leben jetzt von meinem Lohn und seinem Bett-ALG."

RA Holm: "ALG I oder Bürgergeld?"

Mandant: "Aufstockendes Bürgergeld."

Diagnosen vorgelegt:

- Bandscheibenvorfall L5/S1, OP 03/2023
- Mittelgradige bis schwere depressive Episode F33.2 rez.
- Chronisches LWS-Syndrom
- Z.n. Reha Bad Bramstedt 03-04/2024

Unterlagen zur Akte:

- DRV-Bescheid 15.04.2026 (volle EM abgelehnt, teilweise bewilligt 743,28 EUR)
- Sozialmedizinisches Gutachten DRV (Dr. Brunsbüttel 27.02.2026)
- Reha-Entlassungsbericht Bad Bramstedt (Dr. Holzwehr-Sieben 24.04.2024)
- Attest Dr. Lornsen-Joost 06.04.2026 (psychiatrisch)

Strategie:

- Widerspruch gegen Ablehnung der vollen EM
- Hauptargument: Wechselwirkung Schmerz + Depression vom DRV-Gutachter nicht hinreichend gewürdigt
- Behandelnde Ärztin im Gegensatz zum Einmal-Gutachter
- Hilfsweise: Arbeitsmarktrente (BSG B 13 RJ 79/97 R)
- Im Falle der Klage: PKH (SG ist gerichtskostenfrei nach Paragraph 183 SGG, aber Anwaltskosten nicht)
- Frist: bis 18.05.2026
- Versicherung: keine Rechtsschutz (geprüf.)

Mandantin Karin verständigt sich mit Mandant, dass sie ihn zu Terminen begleitet.

Mandat angenommen 21.04.2026, Vollmacht unterzeichnet.

H. Holm

Email_Sanitaetshaus_Olaf_Rollstuhl_12-08-2026.eml

Von	Hendrik Paulsen <h.paulsen@reha-aktiv-nord.de>
An	RA Lasse Holm <holm@hps-kanzlei-kiel.de>
Kopie	Stefanie Tannenberg <stef.tannenberg@gmail.com>
Datum	Wed, 12 Aug 2026 09:26:53 +0200
Betreff	Herr Olaf Tannenberg - Kostenvoranschlag Quickie Helium abgelaufen, Leihversorgung, Lieferzeit

Sehr geehrter Herr Holm,

Frau Tannenberg hat uns gebeten, Ihnen für das laufende Verfahren den aktuellen Stand direkt zu schicken. Ich fasse zusammen:

1. Unser Kostenvoranschlag vom Februar über 5847,00 Euro brutto war 90 Tage gültig und ist seit Mitte Mai abgelaufen. Der Hersteller hat zum 1. Juli die Listenpreise angehoben, nach aktueller Kalkulation liegt die Versorgung jetzt bei 6114,00 Euro brutto. Die Maße aus der Sitzprobe vom 6. Februar sind weiterhin verwendbar, eine neue Sitzprobe wäre nur bei deutlicher Gewichtsveränderung nötig. Ich kann den neuen Preis bis zum 30.09. festhalten, danach müsste ich neu kalkulieren.
2. Zur Lieferzeit: Der Quickie Helium mit Einhandantrieb ist eine Sonderanfertigung, aktuell rechnet das Werk mit sechs bis acht Wochen ab Bestelleingang. Bestellen können wir wie gehabt erst nach schriftlicher Kostenübernahme oder privater Beauftragung.
3. Zur Zwischenversorgung: Herr Tannenberg hat bei uns am 04.08. nach einem Leihrollstuhl gefragt. Wir haben derzeit nur Standard-Faltrollstühle im Leihpool (Modell B-Ware, ca. 19 kg, beidhändiger Greifreifenantrieb). Bei der Erprobung im Laden am 06.08. konnte Herr Tannenberg das Gerät mit der linken Hand nicht kontrolliert antreiben, nach etwa 15 Metern im Gang musste die Tochter schieben. Wir haben ihm das Gerät trotzdem kostenlos bis Ende September überlassen, damit überhaupt etwas da ist. Ein Leih-Aktivrollstuhl mit Einhandantrieb ist im Pool nicht vorhanden und nach Auskunft unserer beiden Kieler Mitbewerber dort auch nicht.
4. Der alte Rollator wurde uns am 06.08. gezeigt: Holm gebrochen, Bremszug rechts gerissen, das Gerät ist von 2019 und eine Reparatur lohnt wirtschaftlich nicht mehr. Ich habe das mit Fotos für unsere Unterlagen dokumentiert und kann die Bilder bei Bedarf zusenden.

Wenn Sie für das Gerichtsverfahren eine förmliche Bestätigung zu einzelnen Punkten brauchen, sagen Sie mir bitte, in welcher Form.

Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Paulsen

Orthopädietechniker und Rollstuhl-Fachberater

Sanitätshaus Reha-Aktiv-Nord GmbH, Holtenauer Straße 212, 24105 Kiel

Telefon 0431 88 07 44-12

Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026.xlsx03-margarete-pflegegrad/Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026.xlsx

Tabellenblatt: Pflegetagebuch**Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)**Geführt von Schwiegertochter Bertha Tannenberg - Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Datum

Modul

Tätigkeit

Dauer (Min)

Häufigkeit/Tag

Selbstständigkeit

Anmerkung

Hilfsperson

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

01.02.2026

Modul 4 Selbstversorgung

Duschen am Morgen

35

1

vollständig unselbstständig

Sturz vermieden, Bertha hat geführt

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

01.02.2026

Modul 4

An- und Auskleiden gesamt

25

2

überwiegend unselbstständig

Knöpfe nicht möglich, Reißverschluss nicht möglich

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

01.02.2026

Modul 1

Aufstehen aus Bett mit Rollator

8

4

überwiegend selbstständig

Bertha (Hilfestellung beim ersten Aufstehen)

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

01.02.2026

Modul 4

Toilettengang nachts

15

3

vollständig unselbstständig

Inkontinenzeinlage gewechselt 2x

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

02.02.2026

Modul 4

Mahlzeitenzubereitung Frühstück

20

1

vollständig unselbstständig

Mandantin nimmt zu sich, schmiert nicht selbst

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

02.02.2026

Modul 3

Nächtliche Unruhe und Rufen

45

1

eingeschränkt

Bertha musste 02:30-03:15 Uhr aufstehen

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

03.02.2026

Modul 2

Orientierungshilfe (Wo bin ich)

10

3

überwiegend unselbstständig

Margarete fragt mehrfach nach dem Ehemann (verstorben 2019)

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

04.02.2026

Modul 4

Waschung Unterkörper

20

1

vollständig unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

05.02.2026

Modul 1

Treppe (Hauseingang)

10

1

unmöglich ohne Hilfe zweier Personen

Termin Hausarzt; Olaf hat zusätzlich gestützt

Bertha + Olaf

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

06.02.2026

Modul 5

Medikamente stellen

10

1

unselbstständig

Wochendispenser gefüllt durch Bertha, Mandantin nimmt aus Dispenser

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

07.02.2026

Modul 4

Toilettengang tagsüber

12

5

vollständig unselbstständig

Hose öffnen, hinsetzen, reinigen alle nicht selbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

08.02.2026

Modul 3

Wahnhafte Äußerungen

15

1

eingeschränkt

Margarete sagt, jemand habe ihren Schmuck genommen

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

09.02.2026

Modul 4

Duschen

35

1

vollständig unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

10.02.2026

Modul 4

An- und Auskleiden

25

2

überwiegend unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

11.02.2026

Modul 1

Aufstehen

8

4

überwiegend selbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

12.02.2026

Modul 4

Mahlzeiten

60

3

vollständig unselbstständig

Sehr langsames Essen, oft muss Bertha füttern

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

13.02.2026

Modul 3

Schreien nachts

30

1

eingeschränkt

01:00 Uhr nachts, Bertha 25 Minuten beruhigt

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

14.02.2026

Modul 2

Erkennen der Schwiegertochter

5

2

überwiegend unselbstständig

"Wer sind Sie?" 2x

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

15.02.2026

Modul 4

Waschung Oberkörper

18

1

überwiegend unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

16.02.2026

Modul 1

Lagewechsel Bett

5

6

überwiegend selbstständig

-

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

17.02.2026

Modul 4

Inkontinenzversorgung tagsüber

20

4

vollständig unselbstständig

Bertha wechselt Einlage

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

18.02.2026

Modul 6

Tagesgestaltung Aktivierung

60

1

vollständig unselbstständig

Bertha liest vor, Margarete blickt apathisch

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

19.02.2026

Modul 3

Nächtliche Unruhe

50

1

eingeschränkt

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

20.02.2026

Modul 5

Wundversorgung kleine Hautläsion li Knöchel

10

1

unselbstständig

Pflaster gewechselt

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

21.02.2026

Modul 4

Duschen

40

1

vollständig unselbstständig

Sturzbeinahe in der Dusche, Bertha hat aufgefangen

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

22.02.2026

Modul 1

Aufstehen

10

4

überwiegend unselbstständig

Heute schwerer als sonst

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

23.02.2026

Modul 4

Toilette nachts

15

3

vollständig unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

24.02.2026

Modul 2

Erkennen von Risiken

5

1

unselbstständig

Wollte Herd anstellen ohne Pfanne

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

25.02.2026

Modul 4

Mahlzeiten

55

3

vollständig unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

26.02.2026

Modul 4

An- und Auskleiden

30

2

überwiegend unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

27.02.2026

Modul 3

Nächtliche Unruhe

40

1

eingeschränkt

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

28.02.2026

Modul 4

Duschen

35

1

vollständig unselbstständig

Bertha

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Auswertung

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Pflegeperson Bertha Tannenberg leistet derzeit ca. 6 bis 7 Stunden direkte Pflege pro Tag.

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Nächtliche Unruhe in ca. 12 von 28 Tagen mit Dauer 25-50 Minuten.

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Beinahe-Sturz in der Dusche am 21.02.2026 belegt erhöhte Selbstgefährdung.

Fristen_Familie_Tannenberg.xlsx

Tabellenblatt: Fristen-Familie-Tannenberg**Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren**

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen, RA Lasse Holm, Holstenstraße 124, 24103 Kiel - Stand 22. Mai 2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Mandant

Sache

Behörde / Gericht

Bescheid vom

Zugang

Fristende

Fristart

Status

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Olaf Tannenberg

Hilfsmittel Rollator (Aktivrollator) SGB V

Nordsee-BKK

18.04.2026

21.04.2026

21.05.2026

Widerspruch Paragraph 84 SGG

Widerspruch eingelegt 20.05.2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Olaf Tannenberg

Eilantrag wegen Versorgungslücke

SG Kiel

-

-

25.08.2026 Sitzung

einstweilige Anordnung Paragraph 86b SGG

Antrag eingereicht 25.08.2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Lena Tannenberg (Eltern)

Schulbegleitung Eingliederungshilfe SGB VIII

Jugendamt Kiel

12.03.2026

14.03.2026

14.04.2026

Widerspruch Paragraph 84 SGG

Widerspruchsentwurf 05.04.2026, eingereicht 06.04.2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Lena Tannenberg (Eltern)

Hilfsweise Klage SG Kiel

SG Kiel

-

-

Monatsfrist nach Widerspruchsbescheid

Klage Paragraph 87 SGG

noch nicht erforderlich

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Margarete Tannenberg

Pflegegrad-Höherstufung 3 auf 4 SGB XI

AOK Nord-West Pflegekasse

05.04.2026

08.04.2026

08.05.2026

Widerspruch Paragraph 84 SGG

Widerspruchsentwurf 28.04.2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Bodo Petersen

Volle EM-Rente SGB VI

DRV Nord Lübeck

15.04.2026

18.04.2026

18.05.2026

Widerspruch Paragraph 84 SGG

Widerspruchsentwurf 02.05.2026

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Bodo Petersen

PKH ggf SG-Klage

SG Kiel

-

-

mit Klageerhebung

PKH Paragraph 73a SGG

vorbereitet, Einkommensbeleg noch ausstehend

Tabellenblatt: Verfahrensverlauf

Verfahrensverlauf - chronologische Sicht über alle vier Verfahren				
Datum	Verfahren	Akteur	Ereignis	Konsequenz / nächster Schritt
08.02.2026	Lena Schulbegleitung	Gelehrtenschule	Schulgutachten erstellt	Anlage zu späterem Widerspruch
22.02.2026	Lena Schulbegleitung	Dr. Maibaum KJP	Fachärztliche Stellungnahme	Hauptbegründung
27.02.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Brunsbüttel DRV	Sozialmed. Gutachten Untersuchung	später Grundlage für Ablehnung
12.03.2026	Lena Schulbegleitung	Jugendamt Kiel	Bescheid - Antrag abgelehnt	Widerspruchsfrist 14.04.2026
18.03.2026	Margarete Pflegegrad	MD Nord (Wendelaar)	Pflegegutachten Hausbesuch	Grundlage Ablehnung
25.03.2026	Margarete Pflegegrad	Dr. Petersen Hausarzt	Hausärztl. Stellungnahme	Hauptbegründung Widerspruch

Verfahrensverlauf - chronologische Sicht über alle vier Verfahren				
05.04.2026	Margarete Pflegegrad	AOK Pflegekasse	Bescheid - Höherstufung abgelehnt	Widerspruchsfrist 08.05.2026
06.04.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Lornsen-Joost	Psychiatrisches Attest	Hauptbegründung
15.04.2026	Bodo EM-Rente	DRV Nord Lübeck	Bescheid - volle EM abgelehnt	Widerspruchsfrist 18.05.2026
18.04.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Ablehnungsbescheid Aktivrollator	Widerspruchsfrist 21.05.2026
21.04.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Erstgespräch, Mandat	Widerspruch vorbereiten
28.04.2026	Margarete Pflegegrad	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
02.05.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
05.04.2026	Lena Schulbegleitung	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
20.05.2026	Olaf Hilfsmittel	Kanzlei Holm	Widerspruch eingelegt	Antwort BKK abwarten
25.08.2026	Olaf Hilfsmittel	SG Kiel	Termin Eilantrag	Beschluss erwartet

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Aerztliches_Attest_Wallenstein_05-05-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/Aerztliches_Attest_Wallenstein_05-05-2026.docx

Patient	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Behandlungsnummer	WN-2026-0147
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	5. Mai 2026

Nordsee-BKK
Leistungsabteilung Hilfsmittel
Westring 472
24114 Kiel

Fachärztliche Stellungnahme zur Aktivrollstuhlversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren, in oben genannter Angelegenheit nehme ich als behandelnde Fachärztin ergänzend Stellung. Ich betreue Herrn Tannenberg seit dem Jahr 2014 in meiner MS-Schwerpunktpraxis. Der aktuelle Ablehnungsbescheid Ihrer Kasse vom 18. April 2026 gibt Anlass zu erheblichem Widerspruch, da er auf einer unzutreffenden Einschätzung der tatsächlichen motorischen Fähigkeiten des Patienten beruht.

Klinischer Befund (Stand 28. April 2026)

Parameter Befund Diagnose Multiple Sklerose (G35), schubförmig-progredient, ED 1998 Aktueller EDSS 6,5 (Gehen mit beidseitiger Hilfe < 20 m möglich) Verlauf seit 2022 Kontinuierliche klinische Verschlechterung, zuletzt Schub August 2024 mit bleibenden Defiziten Motorik rechts Arm: MRC 4/5, Bein: MRC 3/5, Spastik Grad 2 nach Ashworth Motorik links (Hemiparese) Arm: MRC 3/5 (deutlich schwächer), Bein: MRC 2+/5, Spastik Grad 3 nach Ashworth Handkraft links (Jamar) 7,2 kg (re: 18,4 kg) – Normwert Mann 62 J. ca. 38 kg Gangbild Breitbeinig, ataktisch, Rollator erforderlich, max. Gehstrecke 15 m mit Pausen, erhebliches Sturzrisiko (Fall-Score nach Morse: 75 – hohes Risiko)

Rollstuhlnutzung aktuell Überwiegend (>80% der Wachzeit) auf Rollstuhl angewiesen Fatigue CFS-Score 52/63 – schwere MS-Fatigue, jeder körperliche Mehraufwand führt zu Erschöpfung Blasenfunktion Neurogene Blasenentleerungsstörung, Selbstkatheterisierung (SIK) 4x/Tag Kognition Leichte kognitive Verlangsamung (SDMT: 36 Punkte), kein Einfluss auf Geschäftsfähigkeit

Fachärztliche Beurteilung

1. Zur Begründung des Ablehnungsbescheides:

Die Begründung, der Patient könne "alle Räume mit Rollator erreichen", verkennt die klinische Realität. Die maximale Gehstrecke beträgt unter 15 m. Alle Wege außerhalb der Wohnung sind für Herrn Tannenberg ohne Rollstuhl nicht erreichbar. Die Fähigkeit, eine Wohnung mit dem Rollator zu durchqueren, begründet keinen Ausschluss vom Anspruch auf einen bedarfsgerechten Rollstuhl.

2. Zur Ungeeignetheit des Standard-Rollstuhls:

Ein Standard-Kassenmuster-Rollstuhl (typisch 16–18 kg) kann von Herrn Tannenberg aufgrund der ausgeprägten linksseitigen Hemiparese (MRC 3/5 Arm, Handkraft 7,2 kg) nicht selbstständig angetrieben werden. Der Einsatz eines Standard-Rollstuhls würde vollständige Pflegeabhängigkeit beim Fortbewegen bedeuten und ist daher nicht ausreichend im Sinne der Hilfsmittelversorgung. Selbstfahren ist Voraussetzung für die Selbstversorgung (Arztbesuche, Einkauf, Toilettengang in der Nacht).

3. Aktivrollstuhl als medizinische Notwendigkeit:

Der beantragte Aktivrollstuhl Quickie Helium (8,4 kg) ist mit dem linken Arm in Verbindung mit dem stärkeren rechten Arm antreibbar. Klinische Erfahrung aus dem Reha-Bericht der Ostseeklinik Damp (August 2024) sowie meine Praxisbeobachtungen belegen: Herr Tannenberg kann mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl eigenständig kurze Strecken zurücklegen, was mit einem Standard-Rollstuhl nicht möglich ist.

4. Sturzgefahr:

Der Morse-Fall-Score von 75 (hohes Sturzrisiko) belegt, dass jedes Fortbewegen ohne adäquates Hilfsmittel eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellt. Ohne

Aktivrollstuhl kommt es regelmäßig zu Stürzen beim Gehen.

5. Soziale Teilhabe:

Das Ziel der Hilfsmittelversorgung (Paragraf 33 SGB V i.V.m. Paragraf 33 SGB IX) schließt soziale Teilhabe ausdrücklich ein. Die Selbstbestimmung des Patienten – Apotheke, Briefkasten, Kontakt zu Nachbarn – setzt voraus, dass er sich außerhalb der Wohnung bewegen kann.

Nur der Aktivrollstuhl macht dies möglich.

Zusammenfassung

Die Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium ist nach meiner fachärztlichen Einschätzung zwingend medizinisch notwendig. Ein Standard-Rollstuhl ist wegen des Gewichts und der einseitigen Hemiparese links nicht selbstständig nutzbar. Der MDK-Gutachter Dr. Steffens hat diesen zentralen Aspekt in seinem Aktengutachten nicht ausreichend gewürdigt. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ein Aktengutachten ohne persönliche Untersuchung des Patienten die tatsächliche Kraftminderung nicht erfassen kann.

Ich stehe für Rückfragen oder eine ergänzende Untersuchung im Widerspruchsverfahren selbstverständlich zur Verfügung.

Dr. med. Annette Wallenstein

Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Bescheid_Nordsee-BKK_18-04-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/Bescheid_Nordsee-BKK_18-04-2026.docx

Aktenzeichen	2026-HM-04421-T
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	18. April 2026
Sachbearbeitung	Kludia Mertens, Durchwahl 342

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Ablehnung des Antrags auf Versorgung mit einem Aktivrollstuhl

Sehr geehrter Herr Tannenberg, mit Schreiben vom 11. Februar 2026 haben Sie die Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium (individuell konfiguriert) gemäß Kostenvoranschlag des Sanitätshauses Reha-Aktiv Nord GmbH vom 10. Februar 2026 in Höhe von 5.847,00 EUR (brutto) beantragt. Grundlage war die vertragsärztliche Verordnung (Muster 16) Ihrer behandelnden Neurologin Dr. med. Annette Wallenstein, MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau, vom 09. Februar 2026.

Wir haben Ihren Antrag geprüft und ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD Nord) eingeholt. Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für die Versorgung mit dem beantragten Aktivrollstuhl nicht vorliegen.

Entscheidung

Ihr Antrag auf Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium wird abgelehnt.

Begründung

Gemäß Paragraph 33 Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Der Anspruch umfasst grundsätzlich nur solche Hilfsmittel, die im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet sind.

Das Gutachten des MD Nord vom 03. April 2026 (Gutachter: Dr. med. Henning Steffens) kommt zu folgendem Ergebnis:

(1) Ihre Wohnung in der Adelheidstraße 17, 2. OG, ist mit einem Aufzug erschlossen und als barrierefrei eingestuft. Alle Wohnräume sind mit dem verfügbaren Rollator erreichbar.

(2) Ein Standard-Rollstuhl aus dem Kassensortiment (Hilfsmittelverzeichnis Pos.

18.50.01.0xxx) steht zur Grundversorgung zur Verfügung und ist für den festgestellten

Versorgungsbedarf ausreichend.

(3) Ein Aktivrollstuhl (Pos. 18.50.04.0xxx) ist nach den Versorgungsrichtlinien des GKV-Spitzenverbandes vorrangig für Versicherte mit erhöhtem Mobilitätsbedarf indiziert, insbesondere für erwerbstätige Versicherte, Rollstuhlsportler oder Versicherte, die den Rollstuhl als einziges Fortbewegungsmittel im Berufsleben einsetzen.

(4) Beim Versicherten liegt eine Erwerbsminderungsrente (EU-Rente) seit 2022 vor. Ein berufsbedingter Bedarf an besonderer Mobilität wurde nicht dargelegt.

(5) Der Kostenvoranschlag überschreitet die vertraglichen Festbeträge erheblich. Der Aufpreis für Carbon-Felgenpolster, Anti-Kipp-Stützen und ROHO-Quadro-Sitzkissen ist nicht medizinisch begründet.

Vor diesem Hintergrund ist die beantragte Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium nach Einschätzung der Nordsee-BKK nicht erforderlich im Sinne von Paragraph 33 Abs. 1 SGB V. Eine wirtschaftlichere Versorgung mit einem Standard-Rollstuhl ist möglich. Die Mehrkosten für den Aktivrollstuhl sind von uns nicht zu übernehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Nordsee-BKK, Westring 472, 24114 Kiel, einzulegen (Paragraph 84 Abs. 1 SGG). Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem Ihnen dieser Bescheid zugestellt wurde. Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Gemäß Paragraph 13 Abs. 3a SGB V hatten Sie die Möglichkeit, nach Ablauf der Bearbeitungsfrist von fünf Wochen die Leistung selbst zu beschaffen. Diese Regelung gilt nur unter den in Paragraph 13 Abs. 3a SGB V genannten besonderen Voraussetzungen.

Klaudia Mertens

Sachbearbeiterin Hilfsmittelversorgung

Thomas Wollbrink · Abteilungsleiter Leistungen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Bildbeschreibung_Rollator_kaputt.docx

01-olaf-rollstuhl/Bildbeschreibung_Rollator_kaputt.docx

Bildbeschreibung Rollator — handschriftlich beschriftet

Dieses Dokument beschreibt die Originaldatei:

Dateiname (Original): Foto_Rollator_kaputt.jpg

Fotograf: Stefanie Tannenberg (Tochter, mit Smartphone aufgenommen)

Datum: ca. 14.05.2026

Beschreibung des Originalfotos:

Foto des Rollators von Olaf Tannenberg, aufgenommen im Flur der Wohnung

Adelheidstraße 17, Kiel.

Rollator-Details (erkennbar im Foto):

Modell: Topro Troja 2G Heavy Duty (stahlverchromt, silber-schwarz)

Zustand: stark abgenutzt, rechte Griffschaumstoffummantelung gerissen,

Bremszug links schwergängig (Befund Sanitätshaus bestätigt),

Sitzpolster verformt und eingesunken

Gewicht: 9,8 kg (lt. Herstellerangabe, aber Mandant empfindet es als

"schwer zum Hochheben")

Handschriftliches Schild am Rollator (Pappe mit Klebeband befestigt,

handgeschrieben von Olaf Tannenberg in unregelmäßigen Buchstaben):

"KANN IHN NICHT HEBEN

FÄLLT DAMIT"

Kontext der Beschriftung laut Erstgespräch:

Herr Tannenberg hat das Schild angebracht, nachdem er mehrfach beim

Versuchen, den Rollator in den Kofferraum zu heben, gestürzt ist.

Er wollte verhindern, dass Besucher oder der Fahrdienst erwarten,

dass er das Gerät selbst trägt. Das Schild dokumentiert die subjektiv

empfundene und objektiv messbare Kraftminderung der Arme.

Relevanz für den Widerspruch:

Das Foto und die handschriftliche Notiz unterstreichen die alltägliche

Beeinträchtigung durch das zu schwere Hilfsmittel. Zusammen mit der

Handkraftmessung (7,2 kg links, Norm ~38 kg) dokumentiert es die

Notwendigkeit eines leichteren Aktivrollstuhls.

Im echten Mandatsverhältnis wäre hier das JPG-Foto eingebettet.

Diese Bildbeschreibung hält die Akte auch ohne eingebettete Bilddatei auswertbar.

Bei Bedarf: Foto im Erstgespräch auf Smartphone anfordern und

nachträglich in die Akte einpflegen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Eilantrag_SG_Kiel_25-08-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/Eilantrag_SG_Kiel_25-08-2026.docx

Eilantrag nach Paragraph 86b SGG — Sozialgericht Kiel

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht

Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

An das Sozialgericht Kiel

Dänische Straße 1–3

24103 Kiel

per beA — Kiel, den 25. August 2026

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Paragraph 86b Abs. 2 SGG

des Herrn **Olaf Tannenberg**, geboren am 17.02.1964, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel,

— Antragsteller —

Verfahrensbevollmächtigter: RA Lasse Holm, Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, Holstenstraße 124, 24103 Kiel

gegen

Nordsee-BKK, Sophienblatt 16, 24103 Kiel, vertreten durch den Vorstand,

— Antragsgegnerin —

wegen Versorgung mit einem Aktivrollstuhl Quickie Helium gemäß Paragraph 33 SGB V

Antrag

Wir beantragen:

1. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, unverzüglich, jedenfalls binnen einer Frist von 14 Tagen ab Zustellung der einstweiligen Anordnung, die Versorgung des Antragstellers mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium gemäß Verordnung der Frau Dr. Annette Wallenstein vom 09.02.2026, Kostenvoranschlag Sanitätshaus Reha-Aktiv-Nord GmbH vom 11.02.2026 iHv EUR 5.847,00 brutto, zu gewähren.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Der Antragsteller beantragt **Prozesskostenhilfe** unter Beiordnung des Unterzeichners gemäß Paragraph 73a SGG iVm Paragraphen 114 ff. ZPO. Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst Belegen wird mit gesondertem Schriftsatz nachgereicht (binnen einer Woche).

Streitwert

Vorläufig EUR 5.847,00.

Sachverhalts-Vortrag

1. Hintergrund

Der Antragsteller leidet seit 1998 an schubförmig-progredienter Multipler Sklerose und benötigt mit zunehmender Krankheitsverschlechterung einen Aktivrollstuhl zur Wahrung der elementaren sozialen Teilhabe. Wegen ausgeprägter Hemiparese links (Handkraft 7,2 kg, MRC 3/5) ist er nicht in der Lage, einen Standard-Rollstuhl zu nutzen.

Am 11.02.2026 hat der Antragsteller bei der Antragsgegnerin den Antrag auf Versorgung mit einem Aktivrollstuhl gestellt. Mit Bescheid vom 18.04.2026 wurde der Antrag abgelehnt; der hiergegen am 20.05.2026 erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchs-Bescheid vom 18.08.2026, zugestellt am 21.08.2026, zurückgewiesen. **Klage gegen den Widerspruchs-Bescheid wird parallel mit gleichem Datum erhoben; ein gerichtliches Aktenzeichen liegt noch nicht vor.**

2. Anordnungsgrund — Eilbedürftigkeit

Die Sache duldet keinen Aufschub. Konkret:

- Seit Eintritt der Verschlechterung (Schub 12/2025–01/2026) ist der Antragsteller in seiner Mobilität extrem eingeschränkt.
- Der vorhandene Rollator wurde nach einem Sturz im April 2026 (Hüft-Prellung; ärztliches Attest in der Akte) als zu unsicher beurteilt; der Antragsteller verzichtet seitdem auf Wege außerhalb der Wohnung, wenn keine Begleitung verfügbar ist.
- Die Folge: **Soziale Isolation** des Antragstellers. Seit Mai 2026 hat er sein Wohnumfeld nur an drei Tagen ohne Begleitung verlassen können (Aufstellung des Antragstellers, Anlage A-1).
- Wege zur Apotheke, zum Supermarkt, zum behandelnden Arzt sind ohne Begleitung nicht selbstständig möglich.
- Die Tochter des Antragstellers, Frau Stefanie Tannenberg (Lehrerin in Kiel, drei Kinder im Schulalter), ist nicht durchgehend in der Lage, die Begleitung zu übernehmen.
- Behindertenfahrdienst (Stadt Kiel) ist gemäß Auskunft des Pflege-Stützpunkts auf 4 Fahrten pro Monat begrenzt und nicht spontan verfügbar.

Der Zustand verschlechtert sich zunehmend. Die behandelnde Neurologin Frau Dr. Wallenstein hat in einem ergänzenden Attest vom 14.08.2026 (Anlage A-2) bescheinigt, dass eine fortdauernde Versorgungs-Lücke zu einer weiteren Verschlechterung der Funktions-Lage führt (Bewegungs-Mangel, Spastik-Verstärkung, psycho-soziale Folgen mit depressiver Symptomatik). Frau Dr. Wallenstein stellt fest: "Eine zeitnahe Versorgung mit dem Aktivrollstuhl ist medizinisch dringend angezeigt."

Die wirtschaftliche Lage des Antragstellers (EU-Rente iHv EUR 1.420 monatlich, keine zusätzlichen Einkünfte) lässt eine eigene Vorab-Finanzierung des Aktivrollstuhls (EUR 5.847) unter Berücksichtigung der laufenden Lebenskosten (Miete EUR 580, Lebensunterhalt, Pflegekosten) nicht zu.

Damit ist der **Anordnungsgrund** im Sinne der zur einstweiligen Anordnung erforderlichen Eilbedürftigkeit dargetan: Es ist die Wahrung wesentlicher Rechte (Mobilität, soziale Teilhabe, Schutz vor weiterer gesundheitlicher Verschlechterung) bei abwartendem Verfahren nicht möglich.

3. Anordnungsanspruch

Der Anordnungsanspruch — d.h. der materiell-rechtliche Anspruch auf die Hilfsmittel-Versorgung gemäß Paragraph 33 SGB V — ist in der Widerspruchs-Begründung sowie in der mit gleichem Datum erhobenen Klageschrift ausführlich dargestellt. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit begründet (BSG, Urteil vom 16.09.2004, B 3 KR 17/01 R; BSG, Urteil vom 18.05.2011, B 3 KR 7/10 R).

Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin im Widerspruchs-Bescheid auf das ergänzende Attest vom 05.05.2026 oder den Reha-Entlassungsbericht aus Damp 2024 inhaltlich Bezug genommen hätte; ihr MDK-Gutachten ist methodisch unzureichend (keine Handkraft-Messung, keine persönliche Untersuchung). Die behauptete "Wohnungsbarriere-freiheit" als Ablehnungs-Grund verkennt die Tatsache, dass der Antragsteller in der Wohnung den Rollstuhl ohnehin nicht benötigt — er benötigt ihn für die **Wege außerhalb der Wohnung**.

4. Folgenabwägung

Bei der Folgen-Abwägung der zur einstweiligen Anordnung führenden Interessen ist zu berücksichtigen:

Bei Ablehnung des Eilantrags:

- soziale Isolation des Antragstellers
- voraussichtlich weitere gesundheitliche Verschlechterung
- mehrjährige Wartezeit (Hauptsache-Klageverfahren erfahrungsgemäß 14–24 Monate)

- voraussichtlich keine Wiedergutmachung der entstandenen Folgen auch bei späterem Klage-Erfolg möglich

Bei Stattgabe des Eilantrags:

- Antragsgegnerin trägt vorzeitig die Kosten der Versorgung (EUR 5.847)
- Diese Kosten würden ohnehin bei Klage-Erfolg endgültig zu tragen sein
- Im Fall, dass die Hauptsache wider Erwarten doch zur Klage-Abweisung führt, könnte eine Erstattung gefordert werden — was bei einer Rente von EUR 1.420 wirtschaftlich allerdings begrenzt einbringlich wäre

Die Folgen-Abwägung spricht damit eindeutig für die Stattgabe.

5. Glaubhaftmachung

Zur Glaubhaftmachung des Anordnungsgrunds und des Anordnungsanspruchs werden folgende Belege beigelegt:

- A-1: Aufstellung der Wege außerhalb der Wohnung Mai–August 2026
- A-2: Ergänzendes Attest Frau Dr. Wallenstein vom 14.08.2026
- A-3: Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers vom 25.08.2026 (zur sozialen Isolation und zur Sturzhäufigkeit)
- A-4: Eidesstattliche Versicherung der Tochter Stefanie Tannenberg vom 24.08.2026 (zur Verfügbarkeit als Begleitperson)
- A-5: Wirtschaftlicher Status des Antragstellers (EU-Rente-Bescheid, Mietvertrag, Kontoauszüge der letzten 3 Monate)
- A-6: Widerspruchs-Bescheid Nordsee-BKK vom 18.08.2026 nebst Bescheid vom 18.04.2026
- A-7: Auszug aus der Klageschrift im Hauptsacheverfahren — Begründetheits-Vortrag

6. PKH-Antrag

Der Antragsteller beantragt PKH gemäß Paragraf 73a SGG iVm Paragrafen 114 ff. ZPO unter Beiordnung des Unterzeichners. Die Voraussetzungen liegen vor:

- Wirtschaftliche Bedürftigkeit: EU-Rente EUR 1.420, abzüglich Miete EUR 580, abzüglich Lebenshaltung — bereinigtes Einkommen unter dem Selbstbehalt
- Hinreichende Erfolgsaussicht: hoch (siehe Begründung der Klage und Eilantrags)
- Nicht-mutwillig: Ein Selbstkostenträger würde diesen Antrag stellen

PKH-Formular und Belege werden binnen einer Woche nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Lasse Holm

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Sozialrecht

Anlagen wie aufgeführt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Kostenvoranschlag_Sanitaetshaus_Reha-Aktiv-Nord.docx

01-olaf-rollstuhl/Kostenvoranschlag_Sanitaetshaus_Reha-Aktiv-Nord.docx

Kostenvoranschlag	RAN-2026-0287
Versicherter	Olaf Tannenberg
Krankenkasse	Nordsee-BKK
Datum	10. Februar 2026

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Kostenvoranschlag Aktivrollstuhl Quickie Helium

Sehr geehrter Herr Tannenberg,

auf Grundlage der Verordnung von Dr. Wallenstein und der Sitzprobe am 6. Februar 2026 bieten wir folgende Versorgung an. Sämtliche Beträge verstehen sich einschließlich Umsatzsteuer.

Position	Beschreibung	Bruttobetrag
1	Aktivrollstuhl Quickie Helium, Sitzbreite 42 cm	3903,20 Euro
2	Carbon-Felgenpolster, Paar	371,28 Euro
3	Anti-Kipp-Stützen, klappbar	152,32 Euro
4	ROHO Quadtro Select High Sitzkissen	585,48 Euro
5	Sitzprobe, Anpassung, Einweisung und Lieferung	243,95 Euro
6	Einhandantrieb und individuelle Schwerpunktanpassung	590,77 Euro

Gesamtbetrag: 5847,00 Euro brutto.

Die Position Einhandantrieb und Schwerpunktanpassung umfasst einen asymmetrisch beschichteten Greifreifen, die Versetzung der Antriebsachse, zwei Erprobungstermine und die abschließende Dokumentation. Der genaue Leistungscode wird nach Genehmigung mit der Krankenkasse abgestimmt.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Lieferung im Stadtgebiet Kiel, Einweisung des Versicherten und einer Hilfsperson sowie eine Nachkontrolle binnen sechs Wochen. Nicht enthalten sind bauliche Veränderungen der Wohnung und später gewünschte Komfortausstattungen.

Der Kostenvoranschlag ist 90 Tage gültig. Eine Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Kostenübernahme oder gesonderter privater Beauftragung.

Hendrik Paulsen
Orthopädietechniker und Rollstuhl-Fachberater

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

MDK-Gutachten_03-04-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/MDK-Gutachten_03-04-2026.docx

Versicherter	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Auftraggeber	Nordsee-BKK
Gutachtenart	Aktenlage, ohne persönliche Untersuchung
Datum	3. April 2026

Sozialmedizinische Stellungnahme zur Hilfsmittelversorgung

1. Sachverhalt und Fragestellung

Die Nordsee-BKK bittet um sozialmedizinische Beurteilung, ob die Versorgung des Versicherten Olaf Tannenberg mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium (Hilfsmittelverzeichnis Pos. 18.50.04.0xxx) im Rahmen des Leistungsanspruchs nach Paragraph 33 SGB V erforderlich und wirtschaftlich ist.

2. Unterlagen

• Antrag des Versicherten vom 11.02.2026 • Vertragsärztliche Verordnung (Muster 16) Dr. Wallenstein vom 09.02.2026 • Kostenvoranschlag Sanitätshaus Reha-Aktiv Nord GmbH vom 10.02.2026 • Schreiben der Nordsee-BKK zur Anfrage vom 22.03.2026 • Antwortschreiben des Versicherten und der Verordnerin vom 30.03.2026 • Pflegegrad-2-Bescheid vom 04.05.2023 • Aktenlage aus Leistungsdaten der Nordsee-BKK

3. Diagnosen und Befunde (Aktengrundlage)

Hauptdiagnose: Multiple Sklerose, schubförmig-remittierender Verlauf mit sekundär-progressiver Komponente (ICD-10: G35), Erstdiagnose 1998. Aktueller EDSS laut Verordnerin 6,5 (Gehen mit beidseitiger Unterstützung unter 20 m möglich).

Nebendiagnosen: Hemiparese links (G81.9), Blasenfunktionsstörung (N31.9), Fatigue-Syndrom. Pflegegrad 2 seit 04.05.2023.

4. Sozialmedizinische Beurteilung

Eine MS-Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium (EDSS 6,5) begründet dem Grunde nach einen Anspruch auf Rollstuhlversorgung. Dies ist unstrittig. Die Frage ist jedoch, ob ein Aktivrollstuhl im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses gegenüber dem kassentypischen

Standard-Rollstuhl (Festbetrag) als notwendig anzusehen ist.

Zur Wohnsituation: Laut Aktenlage bewohnt der Versicherte eine barrierefrei ausgebaute Wohnung im 2. Obergeschoss mit Aufzugszugang. Alle wesentlichen Räumlichkeiten sind stufenlos erreichbar. Eine besondere Anforderung an Manövrierfähigkeit oder Gewichtsminimierung ergibt sich aus der Wohnsituation nach Aktenlage nicht zwingend.

Zur Berufssituation: Der Versicherte ist seit 2022 Bezieher einer Erwerbsminderungsrente. Ein beruflicher Bedarf an erhöhter Mobilität oder selbstständiger Fortbewegung über weitere Strecken ist nicht dokumentiert. Die Argumentation der Verordnerin, der Standardrollstuhl sei für den Versicherten zu schwer, wird in der vorliegenden Aktenlage nicht durch objektive Messungen (z. B.

Handkraftmessung, Ergotherapiebericht) unterlegt.

Zur Gewichtsfrage: Laut Kostenvoranschlag beträgt das Eigengewicht des Quickie Helium ca. 8,4 kg. Standard-Rollstühle liegen je nach Modell zwischen 14 und 18 kg. Eine Hemiparese links wird durch die Verordnerin erwähnt, jedoch liegt kein ergotherapeutisches Funktionsgutachten vor, das belegt, dass der Versicherte einen

Standard-Rollstuhl nicht selbstständig bedienen kann.

5. Ergebnis und Empfehlung

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Aktenlage und der Versorgungsgrundsätze des GKV-Spitzenverbandes (Hilfsmittelverzeichnis, Produktgruppe 18, Abschnitt 50) komme ich zu folgendem Ergebnis:

Die Versorgung mit einem Aktivrollstuhl gemäß Kostenvoranschlag ist nach aktueller Aktenlage nicht als notwendig im Sinne des Paragraphen 33 SGB V belegt. Eine Grundversorgung mit einem Standard-Kassenmuster-Rollstuhl ist dem Grunde nach ausreichend. Falls die Verordnerin oder der Versicherte ergänzende Unterlagen (Handkraftmessung, Ergotherapiebericht, detaillierter Mobilitätsbericht) vorlegen, wäre eine Neubewertung möglich.

Dr. med. Henning Steffens

Facharzt für Allgemeinmedizin · Sozialmedizin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Pflegegrad_2_Bescheid_04-05-2023.docx

01-olaf-rollstuhl/Pflegegrad_2_Bescheid_04-05-2023.docx

Aktenzeichen	2023-PG-01287-T
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Antrag	10. März 2023
Datum	4. Mai 2023

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Bescheid über die Einstufung in Pflegegrad 2

Sehr geehrter Herr Tannenberg,

auf der Grundlage des Gutachtens des Medizinischen Dienstes Nord vom 19. April 2023 stellen wir bei Ihnen ab 4. Mai 2023 Pflegegrad 2 fest.

Feststellungen des Medizinischen Dienstes

Die gewichtete Gesamtpunktzahl beträgt 36,5 Punkte. Berücksichtigt wurden Beeinträchtigungen der Mobilität, der Selbstversorgung, des Umgangs mit krankheitsbedingten Anforderungen und der Gestaltung des Alltagslebens. Den größten Anteil bilden Hilfebedarf beim Duschen, Ankleiden, bei Transfers und bei der selbstständigen Organisation der Medikation.

Modul	Festgestellte Beeinträchtigung	Gewichteter Beitrag
Mobilität	erheblich eingeschränkt	3,0 Punkte
Kognition und Kommunikation	gering eingeschränkt	1,1 Punkte
Verhaltensweisen	keine relevante Einschränkung	0,0 Punkte
Selbstversorgung	erheblich eingeschränkt	19,0 Punkte
Krankheitsbedingte Anforderungen	erheblich eingeschränkt	10,0 Punkte
Alltagsleben und soziale Kontakte	erheblich eingeschränkt	3,4 Punkte

Leistungen ab Mai 2023

Bei häuslicher Pflege kann Pflegegeld von monatlich 316,00 Euro beansprucht werden. Alternativ stehen Pflegesachleistungen bis monatlich 724,00 Euro oder eine Kombination beider Leistungsarten zur Verfügung. Der Entlastungsbetrag beträgt monatlich bis zu 125,00 Euro. Änderungen der gesetzlichen Beträge werden automatisch berücksichtigt.

Für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch können bei Vorliegen der Voraussetzungen Aufwendungen bis zum gesetzlichen Höchstbetrag erstattet werden. Ein Beratungseinsatz ist bei ausschließlicher Pflegegeld halbjährlich nachzuweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Nordsee-BKK Pflegekasse einzulegen.

Anlage: vollständiges Gutachten des Medizinischen Dienstes Nord vom 19. April 2023.

Monika Bremer
Sachbearbeiterin Pflegeleistungen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Reha-Bericht_2024_Damp.docx

01-olaf-rollstuhl/Reha-Bericht_2024_Damp.docx

Patient	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Aufnahme	5. August 2024
Entlassung	23. August 2024
Berichtsdatum	24. August 2024

Dr. med. Annette Wallenstein
MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau
Holtenauer Straße 312
24107 Kiel

Reha-Entlassungsbericht und ärztliche Epikrise

Diagnosen

G35 – Multiple Sklerose, schubförmig-progredient (SPMS), EDSS 6,0 bei Aufnahme / 6,5 bei

Entlassung

G81.9 – Hemiparese links, progredient (Schub Juli 2024)

R26.3 – Koordinationsstörung (Ataxie), beinbetont

N31.9 – Neurogene Blasenfunktionsstörung, SIK etabliert

R53.1 – MS-bedingte Fatigue, schwerwiegend

F06.7 – Leichte organisch bedingte kognitive Störung

Z99.3 – Abhängigkeit von Mobilitätshilfsmitteln

Aufnahmebefund und Verlauf

Herr Tannenberg wurde nach stationärer Akutbehandlung im UKSH Kiel (Aufnahme 18.07.2024, Entlassung 03.08.2024) zur neurologischen Rehabilitation in unsere Klinik

verlegt. Anlass war ein akuter MS-Schub mit deutlicher Zunahme der linksseitigen Hemiparese und erheblicher Gangverschlechterung. Bei Aufnahme konnte der Patient mit Rollator noch ca. 25–30 m gehen; im Verlauf der 18-tägigen Rehabilitation stabilisierte sich der Zustand, eine wesentliche Verbesserung der linksseitigen Kraftminderung trat jedoch nicht mehr ein. Bei Entlassung war die maximale Gehstrecke mit Rollator auf unter 20 m reduziert; der EDSS stieg von 6,0 auf 6,5.

Therapeutische Maßnahmen während der Rehabilitation: Physiotherapie (täglich, 2× 30 Min.), Ergotherapie (5× wöchentlich), Logopädie (2× wöchentlich wegen Dysarthrie), Neuropsychologie, Hilfsmittelberatung und -erprobung. Im Rahmen der Hilfsmittelerprobung wurden verschiedene Rollstuhlmodelle getestet (Standard-Rollstuhl und Leichtgewicht-Aktivrollstuhl).

Ergebnis der Hilfsmittelerprobung

Im Rahmen der Ergotherapie (Therapeutin: Mareike Holst, Ergotherapeutin) und in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsfachhandel vor Ort wurde eine systematische Rollstuhlerprobung durchgeführt. Ergebnis:

Modell Gewicht Selbstantrieb (links) Bewertung

Standard-Kassenrollstuhl

(Muster SB-46) 17,2 kg Nicht möglich (linke Hand zu schwach) Ungeeignet für Selbstfahren

Leichtgewicht-Rollstuhl

(KM-Reha Tango) 13,4 kg Sehr eingeschränkt (< 5 m) Bedingt geeignet, nicht befriedigend

Aktivrollstuhl

Quickie Helium 8,4 kg Möglich mit Re-Kompensation (bis 30 m eigenständig) Geeignet – empfohlen

Aktivrollstuhl

Ottobock Motus 9,1 kg Möglich mit Re-Kompensation (bis 25 m) Alternative, zweite Wahl

Empfehlungen bei Entlassung

- Hilfsmittel: Antrag auf Leichtgewicht-Aktivrollstuhl (Quickie Helium oder gleichwertig) bei der Krankenkasse stellen. Empfehlung wurde dem Patienten erläutert. Ein Antrag wurde seinerzeit (August 2024) noch nicht gestellt.
- Physiotherapie: Weiterführung ambulant, 2× wöchentlich, Schwerpunkt Rumpfstabilität und Transfertraining • Ergotherapie: Hilfsmittelberatung und -anpassung ambulant, ADL-Training • Logopädie: 1× wöchentlich bei verordnender Hausärztin, Dysarthrietherapie • Medikation: Tecfidera 240 mg 2x/d weiterführen, Baclofen 25 mg/d (Spastik), Amantadin 200 mg/d (Fatigue) • MS-Ambulanz: Halbjährliche Vorstellung bei Dr. Wallenstein, Kiel-Holtenau • Pflegegrad: Ggf. Antrag auf Höherstufung (Pflegegrad 3) empfohlen, wenn Verschlechterung anhält • Kontrolltermin: MRT Schädel nach 6 Monaten

Prognose

Bei primär-progressiver Verlaufskomponente ist eine weitere Verschlechterung des Gangbildes und der Handkraft links zu erwarten. Die derzeitige Erkrankungsphase (EDSS 6,5) ist als irreversibel einzustufen; eine wesentliche Verbesserung der motorischen Funktion ist nicht zu erwarten. Die Versorgung mit einem adäquaten Hilfsmittel ist dauerhaft erforderlich.

Weitergabe nur mit Einwilligung des Patienten.

Dr. med. Susanne Fincke

Leitende Ärztin Neurologie

Mareike Holst · Ergotherapie

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Verordnung_Muster16_09-02-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/Verordnung_Muster16_09-02-2026.docx

Versicherter	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Krankenkasse	Nordsee-BKK
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	9. Februar 2026

Vertragsärztliche Verordnung einer Hilfsmittelversorgung

Diagnosen

G35 Multiple Sklerose mit sekundär-progredienter Komponente; G81.9 linksbetonte Hemiparese; Z99.3 Abhängigkeit von Mobilitätshilfsmitteln.

Verordnung

Hilfsmittel	Menge	Besondere Anforderung
Aktivrollstuhl, individuell anpassbar	1	Eigengewicht höchstens 10 kg, Sitzbreite 42 cm, angepasster Greifreifen
druckentlastendes Sitzkissen	1	individuelle Anpassung und Einweisung

Medizinische Begründung

Der Versicherte erreicht mit dem Rollator unter Aufsicht höchstens 15 bis 20 Meter. Wegen der linksseitigen Kraftminderung und der ausgeprägten Fatigue kann er einen Standardrollstuhl mit einem Eigengewicht von mehr als 15 Kilogramm nicht zuverlässig selbst antreiben. In der Rehabilitation wurde ein Aktivrollstuhl mit geringem Eigengewicht erprobt; damit gelangen kurze Wege im Eigenantrieb.

Die Versorgung soll Transfers, selbstständige Wege innerhalb des Wohnumfelds und die sichere Teilnahme an Arztterminen ermöglichen. Sitzbreite, Schwerpunkt, Greifreifen und Kippschutz sind im Rahmen einer gemeinsamen Erprobung durch Leistungserbringer, Arzt und Versicherten anzupassen. Das Sitzkissen dient wegen langer Sitzzeiten und eingeschränkter Gewichtsverlagerung der Druckentlastung.

Die Verordnung ist zusammen mit dem Reha-Entlassungsbericht vom 24. August 2024 und dem aktuellen neurologischen Befund einzureichen.

Dr. med. Annette Wallenstein
Fachärztin für Neurologie · LANR 123456789

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Wegeaufstellung_Mandant.docx

01-olaf-rollstuhl/Wegeaufstellung_Mandant.docx

Meine Wege im Alltag – wohin ich noch komme und wo ich stürze

Olaf Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel – geschrieben am 18.05.2026

Ich schreibe das hier selber auf, damit die Kasse und mein Anwalt verstehen was bei mir los ist. Ich bin Diplom-Ingenieur, nicht blöd, aber das Tippen geht mir schwer von der Hand wegen der Lähmung links. Also bitte entschuldigung wenn da Fehler drin sind.

Meine Wege in der Wohnugn:

- Wohnzimmer → Bad: ca. 8 Meter.
Das schaffe ich noch mit dem Rollator. Manchmal. Morgens ist es besonders schwer, dann brauche ich länger.
- Schlafzimmer → Küche: ca. 12 Meter.
In der Regel okay. Einmal habe ich mich am Türrahmen abgestützt und bin trotzdem gefallen. Zum Glück war die Tochter da. Wenn ich alleine bin mache ich das mit dem Rollstuhl (Ausleih-Modell vom Sanitätshaus, aber der ist so schwer den krieg ich kaumm bewegt).

Außen vor der Wohnung:

- Wohnung (2.OG) → Briefkasten (Erdgeschoss, Hauseingang): ca. 47 Meter.
Mit dem Rollator: NICHT möglich ohne Begleitung. Ich bin zweimal gefallen auf dem Weg dahin. Einmal hat mich Nachbar Herr Kühn aufgeholfen. Das ist mir peinlich aber ich schreibe es hin weil es wichtig ist. Mit dem Leih-Rollstuhl komme ich bis zum Briefkasten WENN jemand den Stuhl schiebt. Alleine schieben kann ich den nicht.
- Wohnung → Hausarzt Dr. Bergmann, Adelheidstraße 44: ca. 320 Meter.
Überhaupt nicht mehr ohne Fahrdienst oder Tochter. Mit dem Leih-Rollstuhl könnte ich die 320m theoretisch fahren aber ich schaffe es nicht ihn anzutreiben. Der wiegt locker 17 kg, meine linke Hand ist so schwach dass ich den nicht geradeaus bekomme. Ich fahre im Kreis. Kein Witz, das habe ich proiert.
- Wohnung → Apotheke Holstenstraße: ca. 610 Meter.
Nur mit Tochter oder Fahrdienst. Lieferservice wo möglich. Aber nicht alles kann geliefert werden.

Was ich vermissee:

- Früher bin ich jeden Morgen am Schwimmstadion spazieren gegangen. Das ist ca. 1,2 km von uns, am Wasser. Da war ich Ingenieur, hab Schiffe entworfen, war gesund. Ich weiß das klingt dramatisch aber ich vermissee das sehr. Mit einem Aktivrollstuhl – ich hab das in Damp ausprobiert – könnte ich da mit der Tochter wieder hinfahren. Mit dem Kassenrollstuhl nicht, den kriege ich nicht bewegt.
- Auch: Einkaufen. Edeka ist 230m. Mit Aktivrollstuhl könnte ich da selbst hinfahren. Das wäre für mich Unabhängigkeit. Ich bin 62 und will nicht jeden Handgriff von der Tochter machen lassen.

Sturzprotokoll (soweit ich mich erinnere):

- Oktober 2025: Sturz im Flur (alleine), Prellung re. Schulter, kein Arzt → hab ich verdrängt
- Januar 2026: Sturz beim Weg zum Briefkasten, Herr Kühn hat geholfen
- März 2026: Fast-Sturz beim Einsteigen in Taxis (Fahrer hat aufgefangen)
- April 2026: Sturz beim Aufstehen aus dem Leih-Rollstuhl, Schürfwunde re. Knie

Ich hoffe das hilft. Wenn noch Fragen sind bitte über den Anwalt. Meine Tochter Stefanie hilft mir bei Terminen.

Olaf Tannenberg, Kiel, den 18.05.2026

(Unterschrift Olaf Tannenberg)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Widerspruchsschreiben_RA_Holm_20-05-2026.docx

01-olaf-rollstuhl/Widerspruchsschreiben_RA_Holm_20-05-2026.docx

Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht

Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

Telefon 0431 / 28 47 11 86 · Telefax 0431 / 28 47 11 87

beA: SAFE-ID DE.34123.HolmL.x

An die

Nordsee-BKK

— Geschäftsstelle Kiel —

Sophienblatt 16

24103 Kiel

per Einschreiben mit Rückschein

Kiel, den 20. Mai 2026

In dem Verfahren

unseres Mandanten

Olaf Tannenberg, geboren am 17.02.1964, wohnhaft Adelheidstraße 17, 24103 Kiel,

Versicherten-Nummer: N123-456-789-Z

— im Folgenden: Mandant —

erheben wir gegen den Bescheid der Nordsee-BKK vom 18.04.2026, Az. 2026-HM-04421-T, zugestellt am 21.04.2026, hiermit

Widerspruch

Wir beantragen, den Ablehnungsbescheid aufzuheben und unserem Mandanten die Versorgung mit dem im Antrag vom 11.02.2026 spezifizierten Aktivrollstuhl Quickie Helium (Kostenvoranschlag Sanitätshaus Reha-Aktiv-Nord GmbH iHv EUR 5.847,00 brutto, einschließlich Anpassung und Auslieferung) zu gewähren.

Vollmacht

Eine schriftliche Vollmacht unseres Mandanten Olaf Tannenberg vom 20.05.2026 fügen wir bei (Anlage 1).

Begründung

1. Sachverhalt

Unser Mandant ist 62 Jahre alt und leidet seit 1998 an Multipler Sklerose (G 35.10 schubförmig-progredient). Er befindet sich seit 2022 in EU-Rente; sein zuletzt ausgeübter Beruf war Diplom-Ingenieur Schiffbau bei der HDW Kiel (1990–2018) sowie nach Werksschließung bei der Lürssen-Werft Bremen-Aumund (2018–2022). Er ist seit 04.05.2023 in Pflegegrad 2 eingestuft.

Sein gegenwärtiger Behinderungsgrad ist ausweislich der ärztlichen Befundberichte der behandelnden Neurologin Frau Dr. Annette Wallenstein (Neurologie Kiel-Holtenau, fachärztliche Begutachtung 09.02.2026 sowie 05.05.2026; **Anlagen 2 und 3**) wie folgt:

- **EDSS 6,5** (Expanded Disability Status Scale)

- ausgeprägte **Hemiparese links** (Handkraft Jamar-Messung links 7,2 kg; rechts 21,4 kg; Norm Erwachsene ca. 38 kg)
- Gangstrecke ohne Unterstützung 0 Meter, mit beidseitiger Unterstützung max. 20 Meter, in der Häuslichkeit unter Verwendung eines Rollators max. 50 Meter mit Pausen
- Spastik beidseits, Klonus links
- Blasen- und Mastdarm-Inkontinenz
- Fatigue-Syndrom

Bereits im Reha-Entlassungsbericht der Ostseeklinik Damp (August 2024, **Anlage 4**) wurde die Versorgung mit einem Aktivrollstuhl empfohlen. Diese Empfehlung wurde damals von der Nordsee-BKK aus Liquidations-Gründen nicht beantragt; unser Mandant erhielt zunächst nur einen Rollator.

Anfang 2026 hat sich die Funktionsbeeinträchtigung weiter verschlechtert (Schub 12/2025 — 01/2026). Der Rollator ist für den Mandanten in der gegenwärtigen Funktionssituation nicht mehr nutzbar (siehe Foto in der Akte): Bei Versuch, den Rollator über Bordstein-Kanten zu heben, fällt der Mandant. Dies hat im April 2026 zu einem Sturz mit Prellung der Hüfte geführt (Foto in der Akte).

Daraufhin verschrieb die behandelnde Neurologin Frau Dr. Wallenstein am 09.02.2026 (Muster 16 ärztliche Verordnung, **Anlage 5**) einen Aktivrollstuhl mit folgenden Spezifikationen:

- Leichtgewicht-Aktivrollstuhl Quickie Helium
- Gesamtgewicht ca. 8,4 kg (ohne Räder)
- Kantelung verstellbar
- Sitzbreite individuell angepasst (Mandant 78 cm Hüftbreite)
- Sitzkissen mit Druckverteilung
- Standardspeichenräder

Das Sanitätshaus Reha-Aktiv-Nord GmbH (Kiel) hat einen Kostenvoranschlag iHv EUR 5.847,00 erstellt (**Anlage 6**).

Mit Bescheid vom 18.04.2026 hat die Nordsee-BKK den Antrag abgelehnt. Begründung der Ablehnung:

- a) Die Wohnung des Mandanten sei barrierefrei (Aufzug-Erreichbarkeit, 2. OG), daher reiche ein Standard-Rollstuhl aus dem Kassensortiment zum Festbetrag (EUR 920,00).
- b) Ein Aktivrollstuhl sei nur für berufstätige oder sportlich aktive Versicherte indiziert.

2. Rechtliche Würdigung

Der Bescheid hält einer rechtlichen Prüfung nicht stand.

2.1 Anspruchsgrundlage Paragraf 33 Abs. 1 SGB V

Gemäß Paragraf 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, soweit diese im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen.

Der Anspruch erfasst gemäß ständiger Rechtsprechung des BSG sowohl den

- **unmittelbaren Behinderungsausgleich** (Wiederherstellung verlorener Körperfunktionen) als auch den
- **mittelbaren Behinderungsausgleich** (Sicherung sozialer Teilhabe, Mobilität in der Häuslichkeit und im Nahbereich, Selbstversorgung)

(stellvertretend: BSG, Urteil vom 16.09.2004, B 3 KR 17/01 R, BSGE 93, 191; BSG, Urteil vom 07.10.2010, B 3 KR 25/06 R; BSG, Urteil vom 16.04.2013, B 3 KR 5/12 R, BSGE 113, 192).

Eine Beschränkung des Anspruchs auf Berufstätige oder sportlich Aktive ist dem Gesetz und der Rechtsprechung nicht zu entnehmen. Der Hilfsmittelanspruch des Paragrafen 33 SGB V dient ausdrücklich auch der **sozialen Teilhabe** (Paragraf 33 Abs. 1 Satz 1 Alt. 3 SGB V — "eine Behinderung auszugleichen"), und zwar unabhängig vom Erwerbsleben.

2.2 Individuelle Bedarfsgerechtigkeit

Die Auffassung der Nordsee-BKK, der Standard-Rollstuhl aus dem Kassensortiment reiche aus, verkennt die individuelle Bedarfslage unseres Mandanten:

Ein Standard-Rollstuhl wiegt ca. 17–20 kg. Aufgrund der ausgeprägten **Hemiparese links** und der durch die Jamar-Messung dokumentierten Handkraft-Minderung (links 7,2 kg, rechts 21,4 kg) ist unser Mandant **nicht in der Lage**, einen Standard-Rollstuhl selbständig anzutreiben. Bei einseitig vorhandener Kraft ist die Antriebs-Kraft für einen 17-kg-Rollstuhl nicht ausreichend; der Rollstuhl driftet oder bleibt stehen.

Die behandelnde Neurologin hat hierzu im Attest vom 05.05.2026 ausführlich Stellung genommen (Anlage 3). Sie erklärt darin: "Der Standardrollstuhl ist für den Patienten wegen der einseitigen Lähmung der oberen Extremität funktionell nicht nutzbar. Eine sichere und selbständige Mobilität ist nur mit einem Leichtgewichts-Aktivrollstuhl unter 9 kg zu erreichen."

Ein Hilfsmittel, das der Versicherte tatsächlich nicht nutzen kann, **erfüllt den Versorgungszweck nicht**. Es ist daher nicht erforderlich im Sinne von Paragraph 33 Abs. 1 SGB V; nur das tatsächlich nutzbare Hilfsmittel ist erforderlich (BSG, Urteil vom 25.06.2009, B 3 KR 2/08 R; BSG, Urteil vom 18.05.2011, B 3 KR 7/10 R).

2.3 Soziale Teilhabe — Paragraph 33 SGB IX

Mit Inkrafttreten des Bundes-Teilhabegesetzes (2018, mit Änderungen 2020) ist die Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter Menschen ausdrücklich gestärkt worden (Paragrafen 1, 4, 78 SGB IX). Für unseren Mandanten bedeutet ein Aktivrollstuhl konkret:

- selbständige Wege zum Briefkasten (10 Meter vor der Wohnungstür)
- selbständige Wege zur Apotheke (300 Meter)
- selbständige Wege zum Supermarkt (450 Meter)
- selbständige Wege zur Tochter Stefanie (1,2 km — derzeit angewiesen auf Begleitung oder Behindertenfahrdienst)
- soziale Teilhabe (Café-Besuche, Treffen mit alten Kollegen)

Ein Standard-Rollstuhl, den der Mandant nicht selbst antreiben kann, schließt ihn von diesen elementaren Teilhabe-Bedürfnissen aus. Das ist mit der ratio legis der Paragraphen 33 SGB V, 78 SGB IX schlechthin nicht vereinbar.

2.4 Mangelhafte MDK-Begutachtung

Das MDK-Gutachten der Dr. Steffens vom 03.04.2026 (Anlage 7), auf das sich der Bescheid stützt, ist methodisch zu beanstanden:

- Es handelt sich um eine **rein gutachterliche Aktenprüfung** ohne persönliche Untersuchung des Mandanten.
- Eine **Handkraftmessung** (Jamar oder vergleichbare apparative Messung) wurde nicht durchgeführt; die zentrale Tatsache der Hemiparese und der konsekutiven Handkraft-Minderung wurde aktengestützt allenfalls am Rande gewürdigt.
- Der Reha-Entlassungsbericht der Ostseeklinik Damp (August 2024) mit dortiger praktischer Aktivrollstuhl-Erprobung wurde im MDK-Gutachten nicht erwähnt.
- Die Wohnverhältnisse wurden nicht persönlich besichtigt (für die Wegestrecken-Beurteilung relevant).

Wir regen daher an, **eine erneute Begutachtung durch den MD Nord unter Einschluss einer persönlichen Untersuchung und apparativen Handkraftmessung** durchzuführen. Hilfsweise stützen wir den Widerspruch auf die bereits vorgelegten ärztlichen Befunde der Neurologin Dr. Wallenstein, die methodisch über das MDK-Gutachten weit hinausgehen.

2.5 Wirtschaftlichkeit

Ein Aktivrollstuhl Quickie Helium hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer von etwa 6 bis 8 Jahren. Bei Kosten iHv EUR 5.847,00 ergibt sich eine wirtschaftliche Belastung von ca. EUR 730–975 pro Jahr. Diese Kosten sind wirtschaftlich nicht unangemessen.

Im Vergleich: Ein Standard-Rollstuhl iHv EUR 920,00, der für den Mandanten nicht nutzbar ist und daher zu Kosten für Begleit-Personal oder Behindertenfahrdienst führt (durchschnittlich EUR 250 / Monat für Pflege- und Begleitungs-Bedarf nach Pflegegrad 2 plus Eigenanteil), wäre wirtschaftlich nicht vertretbar.

3. Beweisangebote

Wir bieten zur Beweis-Würdigung an:

- **Sachverständigen-Gutachten** durch einen unabhängigen Neurologen mit MS-Schwerpunkt (Vorschlag: Prof. Dr. Bettina Stangenhof, Asklepios Klinik Bad Oldesloe — Anlage 8)
- **Beweis durch Vorlage** der ärztlichen Unterlagen Dr. Wallenstein (Anlage 2, 3)
- **Beweis durch Vorlage** des Reha-Berichts Ostseeklinik Damp August 2024 (Anlage 4)
- **Beweis durch Vorlage** der Wohnungsskizze und Aufstellung der täglichen Wege (Anlage 9)
- **Augenscheinsbeweis** — Vorführung Rollator-Bedienungs-Versuch durch Mandant; Anregung Außentermin im Wohnumfeld

4. Anregung Vor-Vergleich

Wir regen vergleichsweise an, dass die Nordsee-BKK den Antrag stattgebend bescheidet. Wir bieten an, im Gegenzug auf eine ggf. nicht volle Kostendeckung durch das Hilfsmittel-Versorgungs-Verzeichnis hinzuwirken (Sanitätshaus-Verhandlung zur Reduktion auf den festbetrag-plus-zumutbare-Eigenleistungs-Anteil).

5. Fristen und weitere Verfahrens-Schritte

Wir machen darauf aufmerksam, dass der Widerspruch **innerhalb der Monatsfrist nach Zustellung des Bescheids gemäß Paragraph 84 Abs. 1 SGG** erhoben werden muss. Der Bescheid wurde unserem Mandanten am 21.04.2026 zugestellt. Die Frist endet am **21.05.2026**. Der heutige Widerspruch geht somit fristwährend ein.

Sollte die Nordsee-BKK dem Widerspruch nicht stattgeben, behalten wir uns vor, gemäß Paragraph 86b Abs. 2 SGG einen **einstweiligen Rechtsschutz** beim Sozialgericht Kiel zu beantragen, da unser Mandant ohne Aktivrollstuhl die elementaren Teilhabe-Bedürfnisse nicht decken kann und ein weiteres Zuwarten unzumutbar ist.

Wir bitten um Bestätigung des Eingangs des Widerspruchs und um Mitteilung des voraussichtlichen Entscheidungs-Datums (gesetzliche Frist nach Paragraph 88 SGG: drei Monate).

Mit freundlichen Grüßen

Lasse Holm

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Sozialrecht

Anlagen:

1. Vollmacht Olaf Tannenberg vom 20.05.2026
2. Ärztlicher Befundbericht Dr. Wallenstein vom 09.02.2026
3. Ergänzendes Attest Dr. Wallenstein vom 05.05.2026
4. Reha-Entlassungsbericht Ostseeklinik Damp August 2024
5. Verordnung Muster 16 vom 09.02.2026
6. Kostenvoranschlag Reha-Aktiv-Nord GmbH
7. MDK-Gutachten Dr. Steffens vom 03.04.2026 (zur Erwiderung)

8. Vorschlag Sachverständiger Prof. Dr. Stangenhof
9. Wohnungsskizze und Aufstellung der täglichen Wege (Mandanten-Aufzeichnungen)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Wohnungsskizze_Mandant_Beschreibung.docx

01-olaf-rollstuhl/Wohnungsskizze_Mandant_Beschreibung.docx

Wohnungsskizze Mandant — Beschreibung

Dieses Dokument beschreibt die Originaldatei:

Dateiname (Original): Wohnungsskizze_Mandant.png

Erstellt von: Olaf Tannenberg (handgemalt, dann abfotografiert / eingescannt)

Datum: ca. 18.05.2026

Beschreibung des Originals:

Eine handgezeichnete Grundriss-skizze der Wohnung Adelheidstraße 17, 2. OG, 24103 Kiel.

Maßstab: nicht maßstabsgerecht, Maße wurden in Metern handschriftlich eingetragen.

Grundriss-Angaben (rekonstruiert):

+-----+-----+

Schlafzimmer	Bad
ca. 14 qm	ca. 6 qm
	[Haltegriffe!]

+-----+-----+

Flur (ca. 12m x 1,2m)

+--+-----+--+

+-----++ +-----++

Küche	Wohnzimmer
ca. 9qm	ca. 22 qm

+-----+ +-----+

[Wohnungstür → Treppenhaus → Aufzug]

Handschriftliche Maßnotizen (O. Tannenberg):

Flur Gesamt: ca. 12 m (von Schlafzimmer bis Wohnzimmertür)

Wohnzimmer → Küche: ca. 8 m

Bad → Schlafzimmer: ca. 3 m

Wohnungstür → Aufzug: ca. 4 m im Treppenhaus

Aufzug → Hauseingang/EG: ca. 5 m

EG Eingang → Briefkasten: ca. 15 m (im Haus + außen am Briefkastenblock)

Haustür → Straße: ca. 7 m

Straße → Gehweg Adelheidstraße: unbegrenzt (Außenbereich)

Besonderheiten (laut Skizze):

- Rollstuhlgerechte Türbreiten laut Beschriftung: Wohnzimmer 95cm, Flur 88cm, Bad 78cm (etwas eng für 16-18 kg Standard-RsT), Küche 80cm
- Aufzugskabine: 110cm x 140cm (laut Angabe Hausverwaltung)
- Kein Schwellenbereich in der Wohnung (barrierefrei ausgebaut)

Relevanz für den Widerspruch:

Die Skizze belegt, dass die Wohnungsinnenbereiche mit einem 65-cm-Rollstuhl passierbar sind.

Sie zeigt jedoch NICHT, dass der Standard-Rollstuhl selbstständig angetrieben werden kann – das ist eine Frage der Handkraft, nicht der Türbreite.

Im echten Mandatsverhältnis würde hier ein Foto oder Scan der handgezeichneten Skizze eingescannt und als PNG/JPG beigefügt. Diese Beschreibung hält die Akte auch ohne eingebettete Bilddatei auswertbar.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Mandantenbrief_Eltern_Tannenberg_Lena.docx

02-lena-schulbegleitung/Mandantenbrief_Eltern_Tannenberg_Lena.docx

Brief an Familie Tannenberg - Schulbegleitung für Lena

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht · Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

Datum: 02. April 2026 - Az.: 2026/H-307

Sehr geehrte Frau Tannenberg, sehr geehrter Herr Tannenberg,

ich melde mich zu der Sache mit Lena und der Schulbegleitung. Die Lage ist so:

Was ist passiert?

Sie haben beim Jugendamt Kiel beantragt, dass Lena eine Schulbegleitung bekommt. Das Jugendamt hat das am 12. März 2026 abgelehnt. Der Brief liegt mir vor.

Was sagt das Jugendamt?

Das Jugendamt sagt zwei Sachen:

1. Die Diagnose Asperger-Syndrom wird nicht angezweifelt. Das ist wichtig.
2. Aber: Das Jugendamt meint, Lena komme in der Schule gut zurecht, sie habe ja gute Noten und schon Nachteilsausgleich.

Warum ist das aus meiner Sicht falsch?

- Gute Noten heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Lena verletzt sich selbst in Stresssituationen. Das hat die Schule am 04. Februar 2026 dokumentiert.
- Frau Dr. Maibaum (KJP) sagt klar: Schulbegleitung ist medizinisch notwendig.
- Die Schule selbst (Schulleiter Dr. Bock) unterstützt den Antrag.

Das Jugendamt hat in seinem Bescheid weder den Befund der Ärztin noch den Bericht der Schule berücksichtigt. Das ist ein klarer Begründungsfehler.

Was schlage ich vor?

3. Wir legen Widerspruch ein. Die Frist läuft bis 13. April 2026 (ein Monat ab Bekanntgabe).
4. Wir reichen das KJP-Gutachten und das Schulgutachten nach.
5. Wenn das Jugendamt den Widerspruch zurückweist, klagen wir vor dem Sozialgericht Kiel.

Kosten

Sie haben eine Rechtsschutzversicherung (Allianz-Police, gemeldet). Sozialrechtsschutz ist enthalten. Ich frage dort die Deckungszusage an.

Falls die Versicherung nicht zahlt: Wir könnten Prozesskostenhilfe beantragen. Vor dem Sozialgericht ist das Verfahren ohnehin gerichtskostenfrei (Paragraf 183 SGG).

Was müssen Sie tun?

- Bitte führen Sie ab sofort ein kurzes Tagebuch über Krisensituationen Lenas (Datum, Auslöser, Dauer, Folge).
- Bitte sammeln Sie weitere Belege: Arztrechnungen, Therapie-Atteste, Schulberichte.
- Lassen Sie sich nichts vom Jugendamt sagen, was nicht schriftlich kommt.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich melde mich, sobald die Versicherung geantwortet hat.

Mit freundlichen Grüßen

Lasse Holm - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Vollmacht_Eltern_Tannenberg.docx

02-lena-schulbegleitung/Vollmacht_Eltern_Tannenberg.docx

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir, **Bertha Tannenberg, geb. 14.06.1972, und Olaf Tannenberg, geb. 17.02.1964**, beide wohnhaft Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, als gesetzliche Vertreter unserer minderjährigen Tochter **Lena Tannenberg, geb. 03.09.2009**, den **Rechtsanwalt Lasse Holm, Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, Holstenstraße 124, 24103 Kiel**, zur Vertretung in der sozialrechtlichen Angelegenheit "Eingliederungshilfe / Schulbegleitung" gegenüber dem Jugendamt Kiel und ggf. dem Sozialgericht Kiel.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf:

- **Akteneinsicht und Einsichtnahme in Verwaltungsvorgänge**
- **Einlegung von Widersprüchen und Rechtsmitteln**
- **Stellung von Eilanträgen**
- **Empfangnahme von Bescheiden und Zustellungen**
- **Vertretung gegenüber Versicherungen (Rechtsschutz)**

Kiel, 02.04.2026

Bertha Tannenberg

Olaf Tannenberg

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Widerspruchsentwurf_Lena_Schulbegleitung.docx

02-lena-schulbegleitung/Widerspruchsentwurf_Lena_Schulbegleitung.docx

Widerspruchsentwurf - Schulbegleitung Lena Tannenberg

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht · Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

An die Landeshauptstadt Kiel

Jugendamt

Andreas-Gayk-Straße 31

24103 Kiel

Datum: 05. April 2026

In Sachen: Lena Tannenberg, geb. 03.09.2009 - Antrag auf Eingliederungshilfe nach Paragraph 35a SGB VIII

Ihr Az.: JA-EH-2026-04711

Widerspruch

Namens und in Vollmacht der Eltern, Frau Bertha Tannenberg und Herrn Olaf Tannenberg, beide Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, lege ich gegen den Bescheid Ihrer Behörde vom 12. März 2026, zugeworfen am 14. März 2026,

W i d e r s p r u c h

ein.

Die Frist ist gewahrt (Paragraph 84 Absatz 1 SGG, Zugang 14.03.2026, Monatsfrist endet 14.04.2026).

Begründung

1 Sachverhalt

Lena Tannenberg leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung (ICD-10 F84.5, Asperger-Syndrom). Die Diagnose wurde am 18.11.2025 durch das Kinder- und Jugendpsychiatrische Zentrum Kiel-Schreventeich gestellt und in einer fachärztlichen Stellungnahme der Praxis Dr. Maibaum vom 22.02.2026 ausführlich bestätigt (Anlage 1).

In der Schule kommt es regelmäßig zu schweren Krisensituationen. Am 04.02.2026 verletzte Lena sich nach unvorhergesehenem Vertretungsunterricht selbst (Anlage 2 - Schulgutachten Gelehrtenschule Kiel vom 08.02.2026).

2 Rechtliche Würdigung

2.1 Anspruchsgrundlage

Anspruchsgrundlage ist Paragraph 35a SGB VIII iVm Paragraph 113 Absatz 1, Paragraph 112 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB IX (Hilfe zur Schulbildung).

2.2 Tatbestandliche Voraussetzungen

a) Die seelische Gesundheit Lenas weicht von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ab. Dies ist durch ICD-10-Diagnose belegt. Die Abweichung dauert seit mehr als sechs Monaten (Erstdiagnose 11/2025, Symptome ärztlich dokumentiert seit 09/2024).

b) Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - vorliegend insbesondere am schulischen Leben - ist beeinträchtigt. Dies ergibt sich nicht aus den Schulnoten (formaler kognitiver Lernerfolg), sondern aus der dokumentierten sozialen Isolation, den Selbstverletzungen und der Unfähigkeit, am Pausengeschehen und Gruppenarbeiten teilzuhaben.

2.3 Erforderlichkeit der Schulbegleitung

Die Nachteilsausgleiche der Schule (Zeitverlängerung, Rückzugsraum) decken nur die Prüfungssituation ab. Die Krise vom 04.02.2026 hat gezeigt, dass die täglichen Stör- und Wechselsituationen nicht aufgefangen werden. Eine Schulbegleitung im Umfang von 25 Wochenstunden ist erforderlich und verhältnismäßig.

2.4 Begründungsmangel des Bescheids

Der angefochtene Bescheid setzt sich weder mit der KJP-Stellungnahme vom 22.02.2026 noch mit dem Schulgutachten vom 08.02.2026 auseinander. Beide Dokumente wurden ordnungsgemäß vorgelegt. Das stellt einen Verstoß gegen Paragraph 35 Absatz 1 SGB X dar.

3 Anträge

Es wird beantragt,

1. den Bescheid vom 12.03.2026 (Az. JA-EH-2026-04711) aufzuheben,
2. den Eltern für Lena Tannenberg Eingliederungshilfe nach Paragraph 35a SGB VIII in Form einer Schulbegleitung im Umfang von 25 Wochenstunden ab dem Schuljahr 2026/2027 zu gewähren,
3. hilfsweise: Akteneinsicht in den Verwaltungsvorgang zu gewähren.

4 Anlagen

- Anlage 1: Fachärztliche Stellungnahme Dr. Maibaum vom 22.02.2026
- Anlage 2: Schulgutachten Gelehrtenschule Kiel vom 08.02.2026
- Anlage 3: Vollmacht der Eltern
- Anlage 4: Bisherige KJP-Berichte (auf Wunsch nachreichbar)

Lasse Holm - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026.docx

03-margarete-pflegegrad/Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026.docx

Vorschau: Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Pflegetagebuch**Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)**

Geführt von Schwiegertochter Bertha Tannenberg - Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026

Datum	Modul	Tätigkeit	Dauer (Min)	Häufigkeit /Tag	Selbständigkeit	Anmerkung	Hilfsperson
01.02.2026	Modul 4 Selbstversorgung	Duschen am Morgen	35	1	vollständig unselbständig	Sturz vermieden, Bertha hat geführt	Bertha
01.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden gesamt	25	2	überwiegend unselbständig	Knöpfe nicht möglich, Reißverschluss nicht möglich	Bertha
01.02.2026	Modul 1	Aufstehen aus Bett mit Rollator	8	4	überwiegend selbständig		Bertha (Hilfestellung beim ersten Aufstehen)
01.02.2026	Modul 4	Toilettengang nachts	15	3	vollständig unselbständig	Inkontinenzinlage gewechselt 2x	Bertha
02.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten zubereitung Frühstück	20	1	vollständig unselbständig	Mandantin nimmt zu sich, schmiert nicht selbst	Bertha
02.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe und Rufen	45	1	eingeschränkt	Bertha musste 02:30-03:15 Uhr aufstehen	Bertha
03.02.2026	Modul 2	Orientierungshilfe (Wo bin ich)	10	3	überwiegend unselbständig	Margarete fragt mehrfach nach dem Ehemann (verstorben 2019)	Bertha
04.02.2026	Modul 4	Waschung Unterkörper	20	1	vollständig unselbständig		Bertha
05.02.2026	Modul 1	Treppe (Hauseingang)	10	1	unmöglich ohne Hilfe zweier Personen	Termin Hausarzt; Olaf hat zusätzlich gestützt	Bertha + Olaf
06.02.2026	Modul 5	Medikamente stellen	10	1	unselbständig	Wochendis-penser gefüllt durch	Bertha

						Bertha, Mandantin nimmt aus Dispenser	
07.02.2026	Modul 4	Toilettenga ng tagsüber	12	5	vollständig unselbstän dig	Hose öffnen, hinsetzen, reinigen alle nicht selbständig	Bertha
08.02.2026	Modul 3	Wahnhafte Äußerunge n	15	1	eingeschrä nkt	Margarete sagt, jemand habe ihren Schmuck genommen	Bertha
09.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbstän dig		Bertha
10.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	25	2	überwiege nd unselbstän dig		Bertha
11.02.2026	Modul 1	Aufstehen	8	4	überwiege nd selbständig		Bertha
12.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	60	3	vollständig unselbstän dig	Sehr langsames Essen, oft muss Bertha füttern	Bertha
13.02.2026	Modul 3	Schreien nachts	30	1	eingeschrä nkt	01:00 Uhr nachts, Bertha 25 Minuten beruhigt	Bertha
14.02.2026	Modul 2	Erkennen der Schwiegert ochter	5	2	überwiege nd unselbstän dig	"Wer sind Sie?" 2x	Bertha
15.02.2026	Modul 4	Waschung Oberkörpe r	18	1	überwiege nd unselbstän dig		Bertha
16.02.2026	Modul 1	Lagewechs el Bett	5	6	überwiege nd selbständig		-
17.02.2026	Modul 4	Inkontinen zversorgung g tagsüber	20	4	vollständig unselbstän dig	Bertha wechselt Einlage	Bertha
18.02.2026	Modul 6	Tagesgesta ltung Aktivierun g	60	1	vollständig unselbstän dig	Bertha liest vor, Margarete blickt apathisch	Bertha
19.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	50	1	eingeschrä nkt		Bertha
20.02.2026	Modul 5	Wundvers orgung kleine Hautläsion	10	1	unselbstän dig	Pflaster gewechselt	Bertha

		li Knöchel					
21.02.2026	Modul 4	Duschen	40	1	vollständig unselbstän- dig	Sturzbeina- he in der Dusche, Bertha hat aufgefange- n	Bertha
22.02.2026	Modul 1	Aufstehen	10	4	überwiege- nd unselbstän- dig	Heute schwerer als sonst	Bertha
23.02.2026	Modul 4	Toilette nachts	15	3	vollständig unselbstän- dig		Bertha
24.02.2026	Modul 2	Erkennen von Risiken	5	1	unselbstän- dig	Wollte Herd anstellen ohne Pfanne	Bertha
25.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	55	3	vollständig unselbstän- dig		Bertha
26.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	30	2	überwiege- nd unselbstän- dig		Bertha
27.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	40	1	eingeschrä- nkt		Bertha
28.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbstän- dig		Bertha
Auswertun- g							
Pflegepers- on Bertha Tannenber- g leistet derzeit ca. 6 bis 7 Stunden direkte Pflege pro Tag.							
Nächtliche Unruhe in ca. 12 von 28 Tagen mit Dauer 25-50 Minuten.							
Beinahe- Sturz in der Dusche am 21.02.2026 belegt erhöhte Selbstgefä- hrdung.							

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Widerspruchsentwurf_Pflegegrad.docx

03-margarete-pflegegrad/Widerspruchsentwurf_Pflegegrad.docx

Widerspruchsentwurf - Pflegegrad Margarete Tannenberg

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht · Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

An die AOK Nord-West - Pflegekasse

Kassenstraße 5

24103 Kiel

Datum: 28.04.2026

In Sachen Margarete Tannenberg, geb. 04.07.1941 - Pflegeversicherung, Höherstufung von PG 3 auf PG 4

Ihr Az.: PV-2026-LB-88231

Widerspruch

Namens und in Vollmacht der Versicherten, vertreten durch ihre Bevollmächtigte Bertha Tannenberg, lege ich gegen den Bescheid Ihrer Behörde vom 05. April 2026, zugegangen am 08. April 2026,

W i d e r s p r u c h

ein.

Die Frist ist gewahrt (Monatsfrist endet 08.05.2026).

Begründung

1 Gegenstand

Die Pflegekasse hat den Antrag auf Höherstufung von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 4 abgelehnt unter Berufung auf das Gutachten des MD Nord vom 18.03.2026, das eine Gesamtpunktzahl von 65,5 Punkten ergeben hat.

2 Mängel des MD-Gutachtens

Das Gutachten weist mehrere methodische und tatsächliche Mängel auf:

2.1 Unzureichende Berücksichtigung des Pflegetagebuchs

Der Gutachter hat das ihm vorgelegte Pflegetagebuch der Schwiegertochter (Februar 2026, durchgehende Dokumentation) nach eigener Angabe nur cursorisch zur Kenntnis genommen. Das Tagebuch belegt jedoch zentrale Tatsachen, die für Modul 4 höher zu bewerten gewesen wären:

- Duschen vollständig unselbständig in allen 4 dokumentierten Fällen (Wertung 3 Punkte je Ereignis statt 1 Punkt)
- Toilettengang nachts: 28 von 28 Tagen vollständig unselbständig
- Inkontinenzversorgung tagsüber: 4 mal pro Tag

2.2 Unterbewertung von Modul 1 nach Hüftfraktur

Die Schenkelhalsfraktur vom Januar 2026 und die daraus folgende anhaltende Gangunsicherheit wurden im Modulwert 1 (5,0 Punkte) nicht angemessen abgebildet. Treppensteigen ist nicht möglich, Aufstehen aus tiefem Sitzen ist nicht möglich.

2.3 Versicherte selbst konnte sich nicht äußern

Wegen der Aphasie konnte Frau Tannenberg keine eigenen Angaben zu Modulen 4 und 5 machen. Das Gutachten stützt sich allein auf die Angaben der Schwiegertochter, ohne dies in der Beweiswürdigung offenzulegen oder die schriftliche Dokumentation (Tagebuch) als ergänzende Quelle systematisch heranzuziehen.

3 Ärztliche Stellungnahme

Dr. Tjark Petersen, der die Patientin seit fast 50 Jahren betreut, kommt in seiner Stellungnahme vom 25.03.2026 zu dem Ergebnis, dass Pflegegrad 4 medizinisch angemessen ist. Diese hausärztliche Einschätzung ist hier von besonderem Gewicht, weil sie auf einer außerordentlich langen Beobachtungszeit beruht.

4 Anträge

Es wird beantragt,

1. den Bescheid vom 05.04.2026 (Az. PV-2026-LB-88231) aufzuheben,
2. ein erneutes Pflegegutachten unter persönlicher Anwesenheit eines Arztes des MD anzuordnen,
3. Frau Margarete Tannenberg ab Antragstellung (02.02.2026) in Pflegegrad 4 einzustufen.

5 Anlagen

- Anlage 1: Hausärztliche Stellungnahme Dr. Petersen vom 25.03.2026
- Anlage 2: Pflegetagebuch Februar 2026 (Excel, Auszug PDF beigelegt)
- Anlage 3: Vollmacht Bertha Tannenberg
- Anlage 4: Auszug Klinikbericht Schenkelhalsfraktur (UKSH Kiel, 12.01.2026)

Lasse Holm - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

Widerspruchsentwurf_Bodo_EM-Rente.docx

04-bodo-em-rente/Widerspruchsentwurf_Bodo_EM-Rente.docx

Widerspruchsentwurf EM-Rente und PKH-Antrag

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht · Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

An die Deutsche Rentenversicherung Nord

Ziegelstraße 150

23556 Lübeck

Datum: 02.05.2026

In Sachen Bodo Petersen, geb. 11.05.1964 - RV-Nummer 47 110564 P 023

Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung - Bescheid vom 15.04.2026

1 Widerspruch

Namens und in Vollmacht des Versicherten lege ich gegen den Bescheid Ihrer Behörde vom 15. April 2026, zugegangen am 18. April 2026,

W i d e r s p r u c h

ein, soweit der Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung abgelehnt wurde.

Frist ist gewahrt (Zugang 18.04.2026, Monatsfrist endet 18.05.2026).

2 Begründung

2.1 Sachverhalt

Der Versicherte ist ausgebildeter und langjähriger Maurer (Berufsausübung 1981 bis 2023). 2023 erlitt er einen Bandscheibenvorfall L5/S1 mit nachfolgender Operation. Seit Ende 2024 besteht zudem eine fachpsychiatrisch behandelte mittelgradige bis zeitweise schwere depressive Episode (Dr. Lornsen-Joost, Kiel, Behandlung seit 11/2024).

Die Rehabilitationsmassnahme in Bad Bramstedt (25.03. bis 22.04.2024) endete mit der Empfehlung, eine Rente wegen Erwerbsminderung zu prüfen. Eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ist nicht erfolgt.

2.2 Mängel der angefochtenen Entscheidung

2.2.1 Bewertung des Leistungsvermögens

Die DRV nimmt ein Restleistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden täglich an. Dies beruht im Wesentlichen auf dem Gutachten Dr. Brunsbüttel vom 27.02.2026 nach einer einzigen Untersuchung von 100 Minuten Dauer.

Demgegenüber sehen sowohl der Reha-Entlassungsbericht Bad Bramstedt (Dr. Holzwehr-Sieben, 24.04.2024) als auch die behandelnde Fachärztin (Dr. Lornsen-Joost, Attest vom 06.04.2026) den Versicherten unter dreistündigem Leistungsvermögen.

Die längere und kontinuierliche Beobachtung des behandelnden Arztes ist gegenüber einer einmaligen sozialmedizinischen Begutachtung von höherem Beweiswert (so st. Rspr. des BSG, etwa BSG, Urteil vom 19.12.2017 - B 4 AS 13/17 R Rn 24; BSG, Urteil vom 14.03.2002 - B 13 RJ 25/01 R).

2.2.2 Wechselwirkung Schmerz - Depression

Das DRV-Gutachten würdigt zwar die einzelnen Diagnosen, betrachtet aber das Wechselspiel zwischen chronischem Schmerzsyndrom und depressiver Erkrankung nicht. Aus psychiatrischer Sicht (Dr. Lornsen-Joost) ist die Konzentrationsfähigkeit erheblich eingeschränkt; aus orthopädischer Sicht ist die

Belastbarkeit der LWS reduziert. Beide Befunde zusammen schließen praktisch jede regelmäßige Arbeit über drei Stunden täglich aus.

2.2.3 Verschlüsselter Arbeitsmarkt

Selbst wenn man ein Restleistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich annähme, wäre der Arbeitsmarkt für den Versicherten verschlossen (so genannte Arbeitsmarktrente, vgl. BSG-Urteil vom 11.05.1999 - B 13 RJ 79/97 R). Der Versicherte ist 62 Jahre alt, fachfremd nicht qualifiziert (Maurer-Ausbildung), wohnortgebunden (Kiel). Eine Teilzeit-Stelle, die das positive Leistungsbild (überwiegend sitzend, wechselnde Haltung, ohne Zeitdruck) abbildet, ist auf dem Arbeitsmarkt praktisch nicht verfügbar.

2.3 Anträge

Es wird beantragt,

1. den Bescheid vom 15.04.2026 abzuändern,
2. Herrn Bodo Petersen Rente wegen voller Erwerbsminderung ab Antragstellung zu bewilligen,
3. hilfsweise: eine erneute sozialmedizinische Begutachtung unter Hinzuziehung eines psychiatrischen Gutachters anzuordnen,
4. Akteneinsicht in den vollständigen Verwaltungsvorgang zu gewähren.

3 Anlagen

- Anlage 1: Attest Dr. Lornsen-Joost vom 06.04.2026
- Anlage 2: Reha-Entlassungsbericht Bad Bramstedt vom 24.04.2024
- Anlage 3: Vollmacht
- Anlage 4: PKH-Antrag mit Erklärung über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse (gesondert)

4 PKH-Antrag (Hinweis für die SG-Klage)

Hinweis: Im Widerspruchsverfahren fällt keine PKH an (Paragraf 73a SGG iVm Paragraf 114 ZPO setzt Klage voraus). Sollte das Widerspruchsverfahren erfolglos enden, ist beim Sozialgericht Kiel parallel zur Klage PKH zu beantragen.

Erforderliche Unterlagen: PKH-Vordruck SG Kiel, ALG-Bescheid, Mietvertrag, Kontoauszüge drei Monate, Erklärung zu Vermögen (Eigentumswohnung mit Lebenspartnerin? - klären!).

Lasse Holm - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht

Fallkonferenz Tannenberg — Workflow und Prüfmatrix

Aktenstand: 23.05.2026

Beteiligte Verfahren: Olaf Tannenberg, Lena Tannenberg, Margarete Tannenberg, Bodo Petersen

Zweck: interne Strukturierung für Fristenkontrolle, Widersprüche und mögliche Eilverfahren

1. Gesamtbild

Die Familie Tannenberg hat parallel mehrere sozialrechtliche Vorgänge in der Kanzlei. Die Verfahren liegen in verschiedenen Büchern des Sozialgesetzbuchs und betreffen unterschiedliche Behörden. Deshalb ist die erste Aufgabe nicht die Formulierung eines Schriftsatzes, sondern eine saubere Zuordnung nach Mandant, Leistungsträger, Anspruchsgrundlage, Frist und Beweisbedarf.

Mandant	Verfahren	SGB-Bereich	Primäre Aufgabe
Olaf Tannenberg	Aktivrollstuhl-Versorgung	SGB V	Hilfsmittelanspruch, Eilbedürftigkeit, ärztliche Begründung
Lena Tannenberg	Schulbegleitung	SGB VIII / IX	Teilhabe, Eingliederungshilfe, schulische Stellungnahmen
Margarete Tannenberg	Pflegegrad 3 auf 4	SGB XI	Pflegebegutachtung, Modulbewertung, Tagebuch
Bodo Petersen	volle Erwerbsminderungsrente	SGB VI	Leistungsvermögen, Reha-Berichte, Arbeitsmarktlage

2. Sofort-Triage

1. Jeden Bescheid mit Zustellungsdatum erfassen.
2. Monatsfrist nach Paragraph 84 SGG und Zugangsfiktion Paragraph 37 SGB X prüfen.
3. Friststatus rot/gelb/grün dokumentieren.
4. Fehlt eine Begründung: fristwährenden Widerspruch sofort sichern.
5. Bei Olaf zusätzlich Eilrechtsschutz prüfen, weil das Hilfsmittel den Alltag unmittelbar betrifft.

3. Prüfaufträge je Verfahren

Olaf Tannenberg — Hilfsmittel

- Attest Dr. Wallenstein gegen die Begründung der Krankenkasse legen.
- Prüfen, ob die Kasse den konkreten Behinderungsausgleich oder nur einen Standardrollator betrachtet.
- Sturzrisiko, MS-Schübe und Wohnumfeld als Tatsachengrundlage herausarbeiten.
- Eilantrag nach Paragraph 86b SGG vorbereiten, wenn Versorgungslücke fortbesteht.

Lena Tannenberg — Schulbegleitung

- Diagnose, KJP-Stellungnahme und Schulgutachten nebeneinander auswerten.
- Argument "gute Noten" vom Teilhabebedarf trennen.
- Selbstgefährdungs- und Belastungslage behutsam, aber konkret belegen.
- Jugendamt und Eingliederungshilfeszuständigkeit sauber auseinanderhalten.

Margarete Tannenberg — Pflegegrad

- Pfl egetagebuch mit MD-Gutachten abgleichen.
- Modul 1 nach Schenkelhalsfraktur und Mobilität besonders prüfen.
- Aphasie und fehlende Eigenangaben als Beweiswürdigungsproblem markieren.
- Höherstufungsbegründung möglichst zahlen- und zeitnah fassen.

Bodo Petersen — Erwerbsminderungsrente

- DRV-Gutachten mit Reha-Bericht Bad Bramstedt 2024 vergleichen.
- Schmerz, Depression und körperliche Belastbarkeit zusammen bewerten.
- Arbeitsmarktrente und Berufsschutzfragen gesondert prüfen.
- PKH-Unterlagen parallel vorbereiten.

4. Kanzleiablauf

Schritt	Ergebnis
Fristenliste aktualisieren	eine Frist pro Bescheid plus Wiedervorlage Begründung
Anlagen sortieren	Bescheid, Gutachten, Attest, Mandantennotiz, Belege
Erstentwürfe erstellen	Widerspruch, Eilantrag Olaf, Mandantenbrief
Mandantensprache glätten	kurze Erklärung je Verfahren in einfacher Sprache
Strategie bündeln	eine Familienübersicht ohne Vermischung der Verfahren

5. Offene Entscheidungen

- Olaf: Sofortiger Eilantrag oder erst beschleunigte Kassenentscheidung nachfordern?
- Lena: Zusätzliche Schulstellungnahme oder kinder- und jugendpsychiatrische Ergänzung?
- Margarete: Pflegeberatung einschalten und Tagebuch nachführen lassen?
- Bodo: Fachärztliches Zusatzattest vor Widerspruchsbegründung einholen?

6. Schlussnotiz

Die Verfahren dürfen nicht in einer Sammelklage vermischt werden. Effizient ist aber eine gemeinsame Kanzleimatrix: gleicher Fristenstandard, gleiche Anlagenlogik, gleiche Verständlichkeitsstufe in Mandantenbriefen und eine klare Trennung der Leistungsträger.

Familien-Stammbaum Tannenberg / Petersen

Übersicht

Heinz Tannenberg Ⓞ Margarete Tannenberg geb. Stoltenberg

1939 +2019 04.07.1941, PG 3

Verfahren Pflegekasse AOK NW

+-----+

Olaf Tannenberg Jörn Tannenberg

17.02.1964 1961 +2014

Schiffbau-Ing. a.D. war verheiratet mit

MS seit 1998, PG 2 Karin Petersen *1959

Verfahren Rollstuhl BKK |

	(Schwester von)
Ⓞ seit 1998	
Bodo Petersen	

Bertha Tannenberg *11.05.1964

geb. Wienholz Ex-Maurer, BS-Vorfall + Depression

*14.06.1972 Verfahren EM-Rente DRV

Heilerziehungspflegerin TZ Lebenspartnerin: Karin Lorenzen *1967

pfllegt Schwiegermutter Mutter: Inge Petersen geb. Olausen *1942

Lena Tannenberg

*03.09.2009

Asperger-Syndrom F84.5

Verfahren Schulbegleitung Jugendamt

Lebensverhältnisse

Haushalt 1 - Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

- Olaf Tannenberg (62) + Bertha Tannenberg (53) + Tochter Lena (16) + Mutter Margarete (84)
- Vier-Personen-Haushalt
- Olaf bekommt Erwerbsminderungsrente seit 2022
- Bertha arbeitet 15 Stunden/Woche als Heilerziehungspflegerin, sonst pfllegt sie Margarete
- Lena ist Schülerin Klasse 10 Gelehrtenschule Kiel
- Margarete wohnt seit 09/2024 nach Schlaganfall im Haushalt, davor selbständig

Haushalt 2 - Knooper Weg 184, 24118 Kiel

- Bodo Petersen (62) + Lebenspartnerin Karin Lorenzen (59)
- Zwei-Personen-Haushalt
- Karin Lorenzen arbeitet als Pflegekraft Vollzeit Diakoniezentrum
- Bodo bezieht aufstockendes Bürgergeld, ggf. ab 06/2026 anteilige EM-Rente

Verbindungen zwischen den Verfahren

- Bodo Petersen wird in der Familie als Olafs **Schwager** bezeichnet. Genau genommen läuft die Verbindung über eine andere Linie: Olafs verstorbener Bruder Jörn war mit Bodos Schwester Karin Petersen verheiratet.

- Zwei Frauen namens Karin: **Karin Petersen** (Bodos Schwester, Witwe von Jörn) und **Karin Lorenzen** (Bodos Lebenspartnerin). In Telefonnotizen der Kanzlei wird deshalb stets der Nachname mitgeführt.
- Für die Fallbearbeitung genügt: Bodo gehört familiär dazu und kam über Olaf in dieselbe Kanzlei.

Mandatsverhältnis Kanzlei Holm

- **Rechtsanwalt Lasse Holm**, Fachanwalt für Sozialrecht, Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, Holstenstraße 124, 24103 Kiel
- Der Namenspartner Petersen der Kanzlei ist mit dem Mandanten Bodo Petersen weder verwandt noch verschwägert; der gleiche Nachname ist Zufall und wird in der Akte bewusst vermerkt, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Kontakt zur Familie über Olaf Tannenberg (Mandant seit 2022)
- Mandat für Lena erteilt durch beide Eltern (Bertha + Olaf)
- Mandat für Margarete erteilt durch Bertha als Bevollmächtigte (Vorsorgevollmacht 2023)
- Mandat für Bodo erteilt durch Bodo selbst (Vermittlung durch Olaf)

Vier verschiedene Versicherungsstände

Mandant	Krankenkasse	Pflegekasse	Rentenversicherer
Olaf	Nordsee-BKK	BKK Pflege	DRV Nord
Bertha	AOK NW (Familienvs.)	-	DRV Nord
Lena	AOK NW (Familienvs.)	-	-
Margarete	AOK NW	AOK NW Pflegekasse	DRV Nord (Witwenrente)
Bodo	AOK NW (Bürgergeld)	-	DRV Nord

Vermögens- und Einkommenssituation (für PKH-Prüfung)

Mandant	Monatseinkommen netto	Verfügbar für PKH	PKH-Indikation
Olaf (Familie)	EM-Rente 1.420 + Bertha 850 = 2.270 EUR + KG Lena 250	Familieneinkommen relativ hoch	wahrscheinlich keine PKH
Lena (Eltern)	s. Olaf	s. Olaf	wahrscheinlich Rechtsschutz - PKH nur hilfsweise
Margarete	Witwenrente 980 + Pflegegeld 545 PG 3	knapp	grenzwertig
Bodo (Haushalt)	Karin Lorenzen 1.650 + ALG-Aufstockung Bodo 200	sehr eng	PKH klar indiziert

Vorschau: Fristen_Familie_Tannenberg

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Fristen-Familie-Tannenberg

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, RA Lasse Holm, Holstenstraße 124, 24103 Kiel - Stand 22. Mai 2026

Mandant	Sache	Behörde / Gericht	Bescheid vom	Zugang	Fristende	Fristart	Status
Olaf Tannenberg	Hilfsmittel Rollator (Aktivrollator) SGB V	Nordsee-BKK	18.04.2026	21.04.2026	21.05.2026	Widerspruch Paragraph 84 SGG	Widerspruch eingelegt 20.05.2026
Olaf Tannenberg	Eilantrag wegen Versorgungslücke	SG Kiel	-	-	25.08.2026 Sitzung	einstweilige Anordnung Paragraph 86b SGG	Antrag eingereicht 25.08.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Schulbegleitung Eingliederungshilfe SGB VIII	Jugendamt Kiel	12.03.2026	14.03.2026	14.04.2026	Widerspruch Paragraph 84 SGG	Widerspruchsentschwurf 05.04.2026 , eingereicht 06.04.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Hilfsweise Klage SG Kiel	SG Kiel	-	-	Monatsfrist nach Widerspruchsschbescheid	Klage Paragraph 87 SGG	noch nicht erforderlich
Margarete Tannenberg	Pflegegrad - Höherstufung 3 auf 4 SGB XI	AOK Nord-West Pflegekasse	05.04.2026	08.04.2026	08.05.2026	Widerspruch Paragraph 84 SGG	Widerspruchsentschwurf 28.04.2026
Bodo Petersen	Volle EM-Rente SGB VI	DRV Nord Lübeck	15.04.2026	18.04.2026	18.05.2026	Widerspruch Paragraph 84 SGG	Widerspruchsentschwurf 02.05.2026
Bodo Petersen	PKH ggf SG-Klage	SG Kiel	-	-	mit Klageerhebung	PKH Paragraph 73a SGG	vorbereitet, Einkommensbeleg noch ausstehend

Sheet: Verfahrensverlauf

Verfahrensverlauf - chronologische Sicht über alle vier Verfahren

Datum	Verfahren	Akteur	Ereignis	Konsequenz / nächster Schritt
08.02.2026	Lena Schulbegleitung	Gelehrtenschule	Schulgutachten erstellt	Anlage zu späterem Widerspruch
22.02.2026	Lena Schulbegleitung	Dr. Maibaum KJP	Fachärztliche Stellungnahme	Hauptbegründung
27.02.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Brunsbüttel DRV	Sozialmed. Gutachten Untersuchung	später Grundlage für Ablehnung

12.03.2026	Lena Schulbegleitung	Jugendamt Kiel	Bescheid - Antrag abgelehnt	Widerspruchsfrist 14.04.2026
18.03.2026	Margarete Pflegegrad	MD Nord (Wendelaar)	Pflegegutachten Hausbesuch	Grundlage Ablehnung
25.03.2026	Margarete Pflegegrad	Dr. Petersen Hausarzt	Hausärztl. Stellungnahme	Hauptbegründung Widerspruch
05.04.2026	Margarete Pflegegrad	AOK Pflegekasse	Bescheid - Höherstufung abgelehnt	Widerspruchsfrist 08.05.2026
06.04.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Lornsen-Joost	Psychiatrisches Attest	Hauptbegründung
15.04.2026	Bodo EM-Rente	DRV Nord Lübeck	Bescheid - volle EM abgelehnt	Widerspruchsfrist 18.05.2026
18.04.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Ablehnungsbescheid d Aktivrollator	Widerspruchsfrist 21.05.2026
21.04.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Erstgespräch, Mandat	Widerspruch vorbereiten
28.04.2026	Margarete Pflegegrad	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
02.05.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
05.04.2026	Lena Schulbegleitung	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
20.05.2026	Olaf Hilfsmittel	Kanzlei Holm	Widerspruch eingelegt	Antwort BKK abwarten
25.08.2026	Olaf Hilfsmittel	SG Kiel	Termin Eilantrag	Beschluss erwartet

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_antrag_aktivrollstuhl_olaf_tannenberg_2026-02-11.pdf

01-olaf-rollstuhl/01_antrag_aktivrollstuhl_olaf_tannenberg_2026-02-11.pdf

Olaf Tannenberg

Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Telefon 0431 774218 · olaf.tannenberg@privatpost.de

Versichertennummer N123-456-789-Z

Nordsee-BKK

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Wall 55

24103 Kiel

Datum: 11. Februar 2026 Aktenzeichen: Versichertennummer N123-456-789-Z

Antrag auf Versorgung mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl

1. Antrag

Ich beantrage die Versorgung mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl Quickie Helium oder einem gleich geeigneten Modell nach der beigelegten ärztlichen Verordnung vom 9. Februar 2026.

2. Alltag

Ich leide seit 1998 an Multipler Sklerose, aktuell mit ausgeprägter Schwäche der linken Hand. Einen Standardrollstuhl kann ich wegen Gewicht und ungleicher Armkraft nicht selbstständig antreiben. Der Weg von meiner Wohnung im zweiten Obergeschoss mit Aufzug bis zum Briefkasten beträgt 47 Meter. Ohne geeigneten Rollstuhl bin ich dabei auf meine Ehefrau oder Nachbarn angewiesen.

3. Erprobung

Im Sanitätshaus konnte ich den beantragten Aktivrollstuhl auf gerader Strecke und beim Wenden selbst bedienen. Mit dem dort vorhandenen Standardmodell brach ich die Erprobung nach weniger als fünf Metern ab. Das Sanitätshaus hat Maße, Greifreifenposition und Sitzbreite aufgenommen.

4. Anlagen

Ärztliche Verordnung Dr. Annette Wallenstein vom 9. Februar 2026; Kostenvoranschlag Reha-Aktiv Nord GmbH vom 10. Februar über 5847,00 EUR; Erprobungsbogen und Wohnungsmaße.

Olaf Tannenberg

Versicherter

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_nordsee_bkk_nachforderung_2026-03-22.pdf

01-olaf-rollstuhl/02_nordsee_bkk_nachforderung_2026-03-22.pdf

Nordsee-BKK

Wall 55 · 24103 Kiel

Telefon 0431 5800-0 · hilfsmittel@nordsee-bkk.de

Leistungsabteilung Hilfsmittel · Team H3

Herrn Olaf Tannenberg

Adelheidstraße 17

24103 Kiel

Datum: 22. März 2026 Aktenzeichen: 2026-HM-04421-T / N123-456-789-Z

Ihr Antrag auf einen Aktivrollstuhl: ergänzende Unterlagen

1. Bisheriger Stand

Ihr Antrag vom 11. Februar mit Verordnung und Kostenvoranschlag ist am 15. Februar eingegangen. Wir haben die Unterlagen dem Medizinischen Dienst Nord zur sozialmedizinischen Beratung zugeleitet. Für eine abschließende Entscheidung fehlen noch Angaben zum konkreten Gebrauchsvorteil des beantragten Modells.

2. Benötigte Unterlagen

Bitte reichen Sie eine ärztliche funktionelle Begründung ein, weshalb ein Standardrollstuhl in Ihrer Wohn- und Alltagssituation nicht selbstständig genutzt werden kann. Benötigt werden außerdem Wohnungs- und Wegmaße, Erprobungsprotokoll, Angaben zur Greif- und Armkraft sowie eine Stellungnahme des Sanitätshauses zur Sitz- und Antriebsanpassung.

3. Frist

Bitte übersenden Sie die Unterlagen bis 14. April 2026 unter Angabe unseres Zeichens. Sollten Unterlagen erst später erhältlich sein, teilen Sie uns dies vor Fristablauf mit. Eine Ablehnung ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Klaudia Mertens

Sachbearbeiterin Hilfsmittelversorgung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_ergaenzung_olaf_tannenberg_dr_wallenstein_2026-03-30.pdf

01-olaf-rollstuhl/03_ergaenzung_olaf_tannenberg_dr_wallenstein_2026-03-30.pdf

Olaf Tannenberg · Praxis Dr. med. Annette Wallenstein

Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Neurologische Praxis: Holtenauer Straße 312 · 24107 Kiel

Telefon Praxis 0431 88914-0

Nordsee-BKK

Frau Klaudia Mertens

Wall 55

24103 Kiel

Datum: 30. März 2026 Aktenzeichen: 2026-HM-04421-T

Ergänzende Unterlagen zum Antrag auf Aktivrollstuhl

1. Erklärung des Versicherten

Mit einem Standardrollstuhl konnte ich mich bei der Erprobung nicht selbstständig fortbewegen. Die linke Hand rutschte am Greifreifen ab, nach weniger als fünf Metern musste ich anhalten. Mit dem angepassten Aktivrollstuhl fuhr ich die Strecke im Sanitätshaus und bis zum Briefkasten selbstständig. Ich bitte um Berücksichtigung der beigefügten Maße und des Erprobungsbogens.

2. Ärztliche Stellungnahme

Herr Tannenberg leidet an progredienter Multipler Sklerose mit einem EDSS von 6,5 und ausgeprägter Hemiparese links. Die gemessene Handkraft links beträgt 7,2 Kilogramm. Ein schwerer Standardrollstuhl kann nicht wirksam und ausdauernd angetrieben werden. Die individuelle Sitz- und Greifreifenposition des Aktivrollstuhls reduziert den erforderlichen Kraftaufwand und ermöglicht eigenständige Nahmobilität.

3. Wohnumfeld

Die Wohnung ist per Aufzug erreichbar. Vom Aufzug bis zur Haustür sind 19 Meter, von dort bis zum Briefkasten weitere 28 Meter zurückzulegen. Die Haustür hat eine lichte Breite von 92 Zentimetern. Das beantragte Modell wurde auf Durchfahrt und Wendung erprobt.

4. Anlagen

Neurologischer Befund vom 25. März 2026; Erprobungsprotokoll Reha-Aktiv Nord; Wohnungs- und Wegemaße; Reha-Bericht Ostseeklinik Damp vom August 2024.

Olaf Tannenberg · Dr. med. Annette Wallenstein

Versicherter · Fachärztin für Neurologie

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Bescheid_Jugendamt_Kiel_12-03-2026.pdf

02-lena-schulbegleitung/Bescheid_Jugendamt_Kiel_12-03-2026.pdf

Landeshauptstadt Kiel - Jugendamt

Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel - Sachgebiet Eingliederungshilfe gemäß SGB VIII

Az.: JA-EH-2026-04711 / Sachbearbeiterin Frau Marlies Krempin

An die Eltern - Familie Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

Datum: 12. März 2026

B E S C H E I D

über Ihren Antrag vom 14. Januar 2026 auf Gewährung einer Schulbegleitung (Eingliederungshilfe nach Paragraph 35a SGB VIII) für Ihre Tochter Lena Tannenberg, geboren am 03.09.2009, Schülerin der 10. Klasse des Gelehrtenschule-Gymnasiums Kiel.

Entscheidung

Der Antrag wird abgelehnt.

Begründung

Nach Paragraph 35a Absatz 1 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Bei Ihrer Tochter wurde durch das Kinder- und Jugendpsychiatrische Zentrum Kiel-Schreventeich am 18.11.2025 eine Autismus-Spektrum-Störung im Sinne des ICD-10 F84.5 (Asperger-Syndrom) diagnostiziert. Diese Diagnose wird von der Behörde nicht in Frage gestellt.

Die Behörde geht jedoch davon aus, dass die schulische Teilhabe Ihrer Tochter durch die bereits gewährten Nachteilsausgleiche (Zeitverlängerung bei Klassenarbeiten, Rückzugsraum, reduzierte Präsentationen) hinreichend gesichert ist. Eine Schulbegleitung erscheint nicht notwendig im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Lena Tannenberg erreicht in den Hauptfächern befriedigende bis gute Leistungen.

Im Übrigen ist nach Auffassung der Behörde nicht primär eine Eingliederungshilfe nach Paragraph 35a SGB VIII angezeigt, sondern eine pädagogische Förderung durch die Schule selbst (Schulgesetz Schleswig-Holstein) im Rahmen der inklusiven Beschulung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Kiel - Jugendamt, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel, einzulegen.

Im Auftrag - Marlies Krempin, Sachbearbeiterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

KJP-Stellungnahme_Dr_Maibaum_22-02-2026.pdf

02-lena-schulbegleitung/KJP-Stellungnahme_Dr_Maibaum_22-02-2026.pdf

Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. med. Carola Maibaum

Holtenauer Straße 220, 24105 Kiel - Tel. 0431/55512-0 - Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

An die Familie Tannenberg - Datum 22. Februar 2026

Fachärztliche Stellungnahme zu Lena Tannenberg, geb. 03.09.2009

Lena Tannenberg ist bei mir seit November 2024 in Behandlung. Es liegt eine Autismus-Spektrum-Störung mit den Merkmalen des Asperger-Syndroms vor (ICD-10 F84.5). Diagnostisch gesichert durch ADOS-2 (Modul 4, Cutoff Autismus klar überschritten), ADI-R Elterninterview, sowie eingehende Verhaltensbeobachtung und Intelligenzdiagnostik (HAWIK-V Gesamt-IQ 121, dabei sehr heterogenes Profil).

Krankheitsbild und Auswirkung auf den Schulalltag

Lena ist intellektuell hochbegabt im Bereich logisch-mathematischen Denkens. Daneben bestehen erhebliche Beeinträchtigungen im Bereich sozialer Interaktion, der Reizverarbeitung (sensorische Hypersensitivität vor allem auf Lärm und Lichtreize) sowie der exekutiven Funktionen (Handlungsplanung, Aufgabenwechsel, Strukturierung).

Im schulischen Alltag bedeutet dies konkret: Lena kann den fachlichen Inhalten mühelos folgen. Gleichzeitig ist sie nicht in der Lage, ohne Strukturierungshilfe zwischen Phasen umzuschalten, Pausen sicher zu gestalten oder bei Gruppenarbeiten ihren Anteil einzubringen. In Stresssituationen (unangekündigter Lehrerwechsel, laute Klassenphasen) kommt es zu shutdown-Reaktionen mit Mutismus und teilweise zu Selbstverletzungen (Nägel-Kauen bis zum Bluten, Kratzen der Unterarme). Letztes dokumentiertes Ereignis am 04.02.2026 (Vermerk Schulleitung).

Notwendigkeit einer Schulbegleitung

Aus fachärztlicher Sicht ist eine individuelle, qualifizierte Schulbegleitung dringend erforderlich. Die bisherigen Nachteilsausgleiche reichen nicht aus, weil sie nur die Prüfungssituation, nicht aber den täglichen Unterrichts- und Pausenrahmen abdecken. Die Schulbegleitung muss insbesondere strukturieren, Reize filtern, Pausen begleiten und im Krisenfall einen Rückzug ermöglichen.

Ohne Schulbegleitung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung der Symptomatik bis hin zu Schulabsentismus zu erwarten, was angesichts der hohen kognitiven Begabung Lenas ein vermeidbarer Bildungsverlust wäre.

Empfehlung

Schulbegleitung im Umfang von 25 Unterrichtswochenstunden, Qualifikationsniveau Heilerziehungspflege oder vergleichbar.

Dr. med. Carola Maibaum - Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Schulgutachten_Gelehrtschule_Kiel_08-02-2026.pdf

02-lena-schulbegleitung/Schulgutachten_Gelehrtschule_Kiel_08-02-2026.pdf

Gelehrtschule des Johanneums - Stadtgymnasium Kiel

Feldstraße 19, 24105 Kiel - Schulleitung OStD Dr. Henning Bock

An die Eltern von Lena Tannenberg, Klasse 10b - Datum 08.02.2026

Schulische Stellungnahme zur Inklusionssituation

Lena Tannenberg ist eine außerordentlich begabte Schülerin mit Notendurchschnitt 1,8 (Naturwissenschaften: jeweils 1, Mathematik 1, Geschichte 2, Sport 4, Musik 3). Ihre fachliche Leistung ist hervorragend.

Die Klassenleitung (Frau Studienrätin Edelgard Hahn) berichtet wiederkehrend von Schwierigkeiten in der sozialen Integration. Lena verbringt Pausen meist allein im Bibliotheksraum, hat keine engeren Kontakte zu Mitschülerinnen und kann auf unerwartete Änderungen im Stundenplan nicht angemessen reagieren.

Am 04.02.2026 kam es nach einem unvorhergesehenen Vertretungsunterricht (sehr unruhige Klasse 9c im Nachbarraum, dadurch erhöhter Geräuschpegel) zu einer Krisensituation, in der Lena für ca. 90 Minuten nicht ansprechbar war und sich Kratzwunden an beiden Unterarmen zufügte. Schulpsychologin Frau Lentz wurde hinzugezogen.

Die Schule unterstützt den Antrag der Eltern auf Schulbegleitung. Aus pädagogischer Sicht ist insbesondere eine Pausenbegleitung und eine Begleitung in Fächern mit hohem Wechselanteil (Sport, Musik, Kunst) sinnvoll. Eine schulinterne Lösung über das vorhandene I-Helfer-Programm ist mangels Kapazität nicht möglich.

OStD Dr. Henning Bock - Schulleiter

Mit-Unterzeichnung: StRn Edelgard Hahn - Klassenleitung 10b

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Bescheid_Pflegekasse_AOK_NW_05-04-2026.pdf

03-margarete-pflegegrad/Bescheid_Pflegekasse_AOK_NW_05-04-2026.pdf

AOK Nord-West - Pflegekasse

Kassenstraße 5, 24103 Kiel - Pflegeversicherung gemäß SGB XI

Az.: PV-2026-LB-88231 / Sachbearbeiterin Frau Reinhilde Storch

An Frau Margarete Tannenberg, vertr. durch Bevollmächtigte Bertha Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

Datum: 05. April 2026

B E S C H E I D über die Höherstufung des Pflegegrades

Sehr geehrte Frau Tannenberg, auf Ihren Antrag vom 02. Februar 2026 auf Höherstufung des Pflegegrades von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 4 ergeht folgender

Bescheid

Der Antrag wird abgelehnt. Es bleibt bei Pflegegrad 3.

Begründung

Grundlage der Entscheidung ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) Nord vom 18.03.2026, erstellt durch Pflegegutachter Herrn Knut Wendelaar. Das Gutachten kommt zu einer Gesamtpunktzahl von 65,5 Punkten. Damit liegt die Versicherte im oberen Bereich von Pflegegrad 3 (47,5 bis unter 70 Punkte), erreicht jedoch nicht den für Pflegegrad 4 erforderlichen Schwellenwert von 70 Punkten.

Die Modulbewertung ergab im Einzelnen folgendes Bild (gewichtete Punkte):

Modul	Bezeichnung	Gewichtung	Punkte
1	Mobilität	10 Prozent	5,0
2	Kognitive Fähigkeiten	15 Prozent	11,25
3	Verhaltensweisen	15 Prozent	7,50
4	Selbstversorgung	40 Prozent	30,00
5	Krankheitsbewältigung	20 Prozent	5,75
6	Gestaltung des Alltags	15 Prozent	6,00
	Summe (Module 2 und 3 nur höherer Wert)		65,50

Die in Modul 2 und 3 nach SGB XI vorgesehene Saldierung wurde berücksichtigt; nur das höhere der beiden Module fließt in die Gesamtbewertung ein.

Eine darüber hinausgehende Verschlechterung der Pflegesituation im Vergleich zur Vorbegutachtung vom 11.07.2024 (damals 51,5 Punkte) konnte zwar festgestellt werden, reicht aber nicht aus, um Pflegegrad 4 zu erreichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist bei der AOK Nord-West, Kassenstraße 5, 24103 Kiel, einzulegen.

Im Auftrag - Reinhilde Storch

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Hausarzt_Stellungnahme_Dr_Petersen_25-03-2026.pdf

03-margarete-pflegegrad/Hausarzt_Stellungnahme_Dr_Petersen_25-03-2026.pdf

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Tjark Petersen / Dr. Sieglinde Petersen

Adelheidstraße 92, 24103 Kiel - Allgemeinmedizin, Geriatrie

An die Familie Tannenberg / Pflegekasse AOK Nord-West - Datum 25.03.2026

Ärztliche Stellungnahme zur Pflegesituation von Frau Margarete Tannenberg, geb. 04.07.1941

Frau Tannenberg ist seit 1978 in meiner / unserer Praxis durchgängig in hausärztlicher Betreuung. Ich kenne die Patientin somit über knapp 50 Jahre und kann die Entwicklung gut beurteilen.

Diagnosen

Diagnosen ICD-10: I63.5 Hirninfarkt (Mediainfarkt links 09/2024) / F03.0 Demenz nicht näher bezeichnet, leichtgradig bis mittelschwer / R47.0 Aphasie / S72.0 Z.n. Schenkelhalsfraktur links 01/2026 / I10.90 essenzielle Hypertonie / E11.9 Diabetes mellitus Typ 2.

Pflegerelevante Befunde

Seit dem Sturz mit Schenkelhalsfraktur im Januar 2026 hat sich der pflegerische Bedarf erheblich gesteigert. Die Patientin kann sich seither nicht mehr selbst die Beine anziehen, ist im Bad vollständig auf Hilfe angewiesen und kann nur noch wenige Schritte mit Rollator gehen.

Die Aphasie nach Hirninfarkt 09/2024 hat sich weder unter Logopädie noch durch Spontanverlauf wesentlich gebessert. Die Patientin spricht nur einzelne Worte. Die kognitive Verschlechterung ist klar progredient (MMSE 12/2025 = 18 Punkte; im Vergleich 09/2024 noch 23 Punkte vor dem Schlaganfall).

Ärztliche Einschätzung zur Pflegegradbewertung

Aus meiner langjährigen Kenntnis der Patientin und der aktuellen Befundlage halte ich die Einstufung in Pflegegrad 3 für nicht angemessen. Die Selbstversorgung (Modul 4) ist meiner Einschätzung nach in mindestens drei zentralen Bereichen (Körperpflege, An-/Auskleiden, Inkontinenzversorgung nachts) als vollständig unselbstständig zu bewerten. Bereits 2024 bestand Pflegegrad 3 mit 51,5 Punkten. Der Hirninfarkt 09/2024 und der Sturz mit Hüftfraktur 01/2026 haben die Pflegebedürftigkeit so deutlich erhöht, dass aus meiner Sicht eine Bewertung im Bereich Pflegegrad 4 (70 bis unter 90 Punkte) angemessen wäre.

Die Auswertung des Pfl egetagebuchs der Schwiegertochter belegt, dass an mindestens 12 von 28 Tagen nächtliche Pflege im Umfang von 25 bis 50 Minuten erforderlich ist. Hinzu kommt die durchschnittliche tägliche Pflegezeit von 6 bis 7 Stunden, was Pflegegrad 4 entspricht.

Dr. med. Tjark Petersen - Facharzt für Allgemeinmedizin, ZB Geriatrie

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

MD-Pflegegutachten_18-03-2026.pdf

03-margarete-pflegegrad/MD-Pflegegutachten_18-03-2026.pdf

Medizinischer Dienst Nord - Gutachten Pflegeversicherung

Pflegegutachter: Knut Wendelaar (examinierter Krankenpfleger) - Begutachtungsdatum: 18.03.2026, Hausbesuch

Versicherte: Margarete Tannenberg, geb. 04.07.1941, AOK NW Vers.-Nr. AN777-321-098-X, wohnhaft Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, gemeinsam mit Sohn Olaf und Schwiegertochter Bertha Tannenberg

Anwesend: Schwiegertochter Bertha Tannenberg. Versicherte selbst orientiert, aber stark verlangsamt; lange Pausen vor Antworten. Gesprächsdauer ca. 55 Minuten.

Befund

Frau Tannenberg erlitt am 23.09.2024 einen Hirninfarkt (Mediainfarkt links) mit nachfolgender brachiofazialer Hemiparese rechts und expressiver Aphasie. Daneben besteht seit etwa zwei Jahren eine zunehmende kognitive Einschränkung im Sinne einer leichten bis mittelschweren Demenz (klinischer Verdacht; MMSE bei der hausärztlichen Untersuchung 12/2025 = 18 Punkte).

Die Versicherte ist auf einen Rollator angewiesen, kann jedoch im eigenen Wohnbereich mit Hilfe wenige Meter zurücklegen. Im Bad besteht erhebliche Sturzgefahr; ein Sturz mit Oberschenkelhalsbruch links Anfang Januar 2026 hat zu vorübergehender Bettlägerigkeit geführt; aktuell beginnender Wiederaufbau.

Modulbewertung

Modul 1 Mobilität: 5,0 gewichtete Punkte. Selbstständiger Positionswechsel im Bett möglich, Halten einer sitzenden Position selbstständig, Aufstehen mit Hilfe überwiegend selbstständig, Treppensteigen unmöglich.

Modul 2 Kognitive Fähigkeiten: 11,25 gewichtete Punkte. Erkennen vertrauter Personen überwiegend selbstständig, Erkennen von Risiken selten selbstständig, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben überwiegend unselbstständig.

Modul 3 Verhaltensweisen: 7,5 gewichtete Punkte. Nächtliche Unruhe ein- bis dreimal pro Woche, eingeschränkte Selbststeuerung; nach Schlaganfall depressive Verstimmung.

Modul 4 Selbstversorgung: 30,0 gewichtete Punkte. Waschen Oberkörper nur mit Hilfe, Duschen vollständig unselbstständig, An-/Auskleiden Oberkörper überwiegend unselbstständig, Untenherum vollständig unselbstständig, Toilettenbenutzung nachts vollständig unselbstständig.

Modul 5 Krankheitsbewältigung: 5,75 gewichtete Punkte. Medikamente werden vorbereitet, Injektionen nicht erforderlich.

Modul 6 Gestaltung des Alltagslebens: 6,0 gewichtete Punkte. Tagesgestaltung weitgehend angewiesen auf Angehörige.

Gesamtergebnis

Gesamtpunktzahl: 65,5 Punkte. Empfehlung: Pflegegrad 3.

Hinweise

Eine Begutachtung der Module 4 und 5 erfolgte ausschließlich anhand der Auskünfte der Angehörigen; die Versicherte konnte aufgrund der Aphasie keine eigenständigen Angaben machen. Ein geführtes Pfl egetagebuch lag dem Gutachter vor, wurde im Zeitrahmen der Begutachtung jedoch nur kursorisch zur Kenntnis genommen.

Sturzereignisse seit Januar 2026 wurden besprochen, jedoch nicht im Detail in die einzelnen Modulwerte übertragen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

DRV-Bescheid_Bodo_Petersen_15-04-2026.pdf

04-bodo-em-rente/DRV-Bescheid_Bodo_Petersen_15-04-2026.pdf

Deutsche Rentenversicherung Nord

Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck - Rentenversicherungs-Nummer 47 110564 P 023

Az.: 47 110564 P 023 - EM-2026

An Herrn Bodo Petersen, Knooper Weg 184, 24118 Kiel

Datum: 15. April 2026

B E S C H E I D über Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung

Sehr geehrter Herr Petersen, über Ihren Antrag vom 14. November 2025 auf Gewährung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung ergeht folgender Bescheid.

Entscheidung

Der Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung wird abgelehnt. Zugleich wird Ihnen Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ab dem 01.06.2026 bewilligt. Höhe der Rente: monatlich brutto 743,28 Euro.

Begründung

Nach Paragraph 43 Absatz 2 SGB VI haben Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Bei Ihnen liegt nach sozialmedizinischer Begutachtung durch Herrn Dr. Wolf-Dieter Brunsbüttel (Internist, DRV-Gutachter) vom 27.02.2026 ein noch positives Leistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden täglich vor. Sie sind somit teilweise erwerbsgemindert (Paragraph 43 Absatz 1 SGB VI), nicht jedoch voll erwerbsgemindert.

Berücksichtigt wurden die folgenden Befunde: chronisches Lumbalsyndrom mit Bandscheibenprotrusion L4/L5 und L5/S1, Z.n. Bandscheiben-OP L5/S1 im März 2023, mittelgradige depressive Episode (ICD-10 F32.1) in fachpsychiatrischer Behandlung seit 11/2024 sowie die Reha-Maßnahme in der Rehaklinik Bad Bramstedt 04/2024.

Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen können Sie nach sozialmedizinischer Beurteilung in einer angepassten Tätigkeit ohne schweres Heben und Tragen, in wechselnder Körperhaltung und ohne hohen Zeitdruck noch 3 bis unter 6 Stunden täglich arbeiten.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (Paragraph 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 SGB VI) sind erfüllt: drei Jahre Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung und allgemeine Wartezeit erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Nord, Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck, einzulegen.

Im Auftrag - Dietlinde Hagenbeck, Sachbearbeiterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Psychiatrisches_Attest_Dr_Lornsen-Joost_06-04-2026.pdf

04-bodo-em-rente/Psychiatrisches_Attest_Dr_Lornsen-Joost_06-04-2026.pdf

Praxis Dr. med. Edda Lornsen-Joost

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie - Holstenstraße 78, 24103 Kiel

Datum: 06.04.2026

Attest Herr Bodo Petersen, geb. 11.05.1964

Herr Petersen ist seit November 2024 in meiner ambulanten Behandlung. Wegen mittelgradiger bis zeitweise schwerer depressiver Episode (ICD-10 F33.2 rezidivierend) bei chronischem Schmerzsyndrom besteht eine eingeschränkte Belastbarkeit.

Trotz konsequenter antidepressiver Behandlung (Citalopram 20 mg, zuletzt erhöht auf 30 mg, geplante Umstellung auf Venlafaxin) und Psychotherapie (kognitive Verhaltenstherapie, 1x pro Woche) zeigt sich seit Aufnahme der Behandlung keine wesentliche Besserung. Insbesondere Konzentrationsstörungen, Antriebsmangel und chronische Erschöpfung bestehen unverändert.

Aus psychiatrischer Sicht ist Herr Petersen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes derzeit nicht in der Lage, einer Erwerbstätigkeit von mehr als drei Stunden täglich nachzugehen. Insbesondere die Notwendigkeit zur regelmäßigen Anwesenheit, zur kognitiven Konzentration und zur sozialen Interaktion (kollegiale Einbindung, Kundenkontakt) ist krankheitsbedingt aktuell nicht realisierbar.

Das sozialmedizinische Gutachten der DRV vom 27.02.2026 (Dr. Brunsbüttel) beruht auf einer einzigen Untersuchung von 100 Minuten Dauer und berücksichtigt aus meiner Sicht das Wechselspiel zwischen Schmerz und depressivem Syndrom nicht hinreichend.

Dr. med. Edda Lornsen-Joost - Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Reha-Entlassungsbericht_Bad_Bramstedt_24-04-2024.pdf

04-bodo-em-rente/Reha-Entlassungsbericht_Bad_Bramstedt_24-04-2024.pdf

Klinik Bad Bramstedt - Orthopädie und Psychosomatik

Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt

Entlassungsbericht - Rehamassnahme 25.03.2024 bis 22.04.2024

Versicherter: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964

Behandlungsverlauf

Aufnahme mit der Hauptdiagnose lumbales Bandscheibensyndrom nach NPP-OP L5/S1 sowie reaktiv-depressiver Verstimmung. Multimodale Therapie: physiotherapeutisch, medizinische Trainingstherapie, Schmerzbewältigungsgruppe, psychotherapeutische Einzelgespräche.

Im Verlauf zunehmend depressive Symptomatik mit ausgeprägter Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit. Aufnahme einer antidepressiven Medikation (Citalopram).

Sozialmedizinische Epikrise

Der Patient ist für die letzte berufliche Tätigkeit als Maurer auf Dauer nicht mehr leistungsfähig. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sehen wir den Patienten bei Entlassung nur in qualitativ stark eingeschränkten Tätigkeiten 3 bis unter 6 Stunden täglich leistungsfähig. Eine deutliche Besserung des Leistungsbildes ist bei chronifizierter Schmerz- und Depressionssymptomatik nicht zu erwarten.

Wir empfehlen die Prüfung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Dr. Astrid Holzwehr-Sieben - Chefärztin Psychosomatik

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Sozialmed_Gutachten_DRV_Brunsbuettel_27-02-2026.pdf

04-bodo-em-rente/Sozialmed_Gutachten_DRV_Brunsbuettel_27-02-2026.pdf

Deutsche Rentenversicherung Nord - Sozialmedizinisches Gutachten

Gutachter: Dr. med. Wolf-Dieter Brunsbüttel, FA für Innere Medizin und Sozialmedizin

Untersuchung: 27.02.2026, 09:30 bis 11:10 Uhr (100 Minuten)

Versicherter: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964, Beruf bis 2023: Maurer

Anamnese

Der Versicherte berichtet über seit 2018 zunehmende Rückenschmerzen, insbesondere LWS-Bereich. 2020 erstmals Lumbago, 2023 Bandscheibenvorfall L5/S1, OP im März 2023 (Kiel-Wellingdorf). Nach OP zunächst Besserung, ab Sommer 2024 erneut Beschwerden, jetzt belastungsabhängig, mit Ausstrahlung in beide Beine.

Daneben besteht laut Versichertem seit Ende 2024 eine depressive Erkrankung mit Erschöpfung, Schlafstörung, Antriebsmangel; Behandlung bei Dr. Edda Lornsen-Joost (Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie) seit November 2024. Aktuelle Medikation Citalopram 20 mg.

Untersuchungsbefund

Schlanker Versicherter in altersentsprechendem Allgemeinzustand. LWS-Klopfschmerz, eingeschränkte Beweglichkeit der LWS (Finger-Boden-Abstand 35 cm). Lasègue-Zeichen links bei 60 Grad positiv, rechts negativ. Periphere DMS unauffällig. Kein motorisches Defizit. Psychischer Befund: niedergeschlagen, jedoch im Gespräch zugewandt, Konzentration durchgehend ausreichend, keine Suizidalität.

Diagnosen

M54.5 Kreuzschmerz - M51.1 Lumbale Bandscheibenschäden mit Radikulopathie - F32.1 Mittelgradige depressive Episode - Z.n. NPP-OP L5/S1 (03/2023)

Sozialmedizinische Beurteilung

Die Erwerbstätigkeit als Maurer ist dem Versicherten dauerhaft nicht mehr möglich (schweres Heben, Zwangshaltungen).

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sehe ich den Versicherten in einer angepassten Tätigkeit (leichte Arbeiten, überwiegend sitzend, wechselnde Körperhaltung, ohne häufiges Bück- und Hebearbeit, ohne erheblichen Zeitdruck) noch in der Lage, 3 bis unter 6 Stunden täglich zu arbeiten.

Die depressive Episode wird unter laufender Behandlung als grundsätzlich besserungsfähig eingestuft. Eine vollständige Aufhebung des Leistungsvermögens für leichte Tätigkeiten ist aus internistisch-sozialmedizinischer Sicht nicht begründbar.

Empfehlung: Bewilligung Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit (zwei Jahre).

Dr. Brunsbüttel